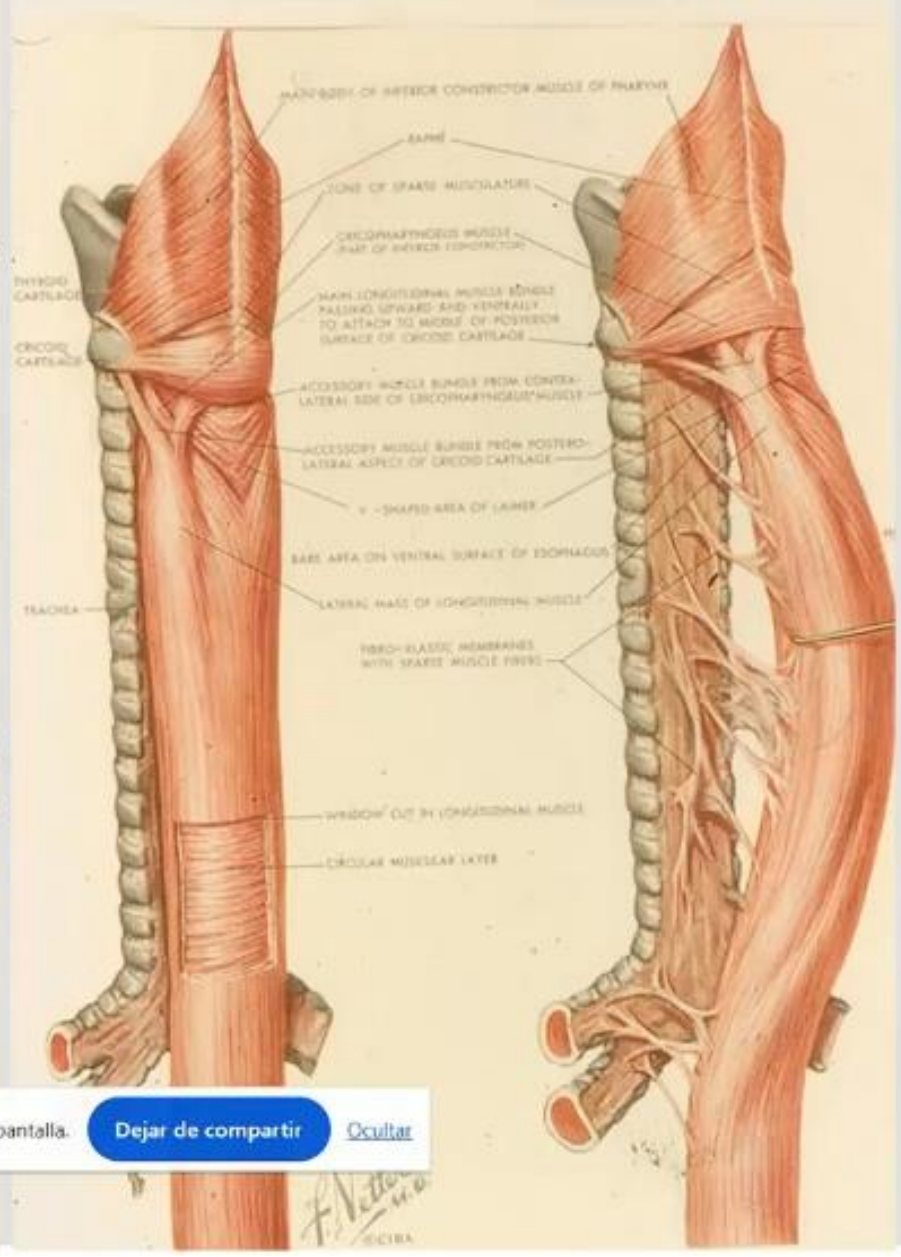
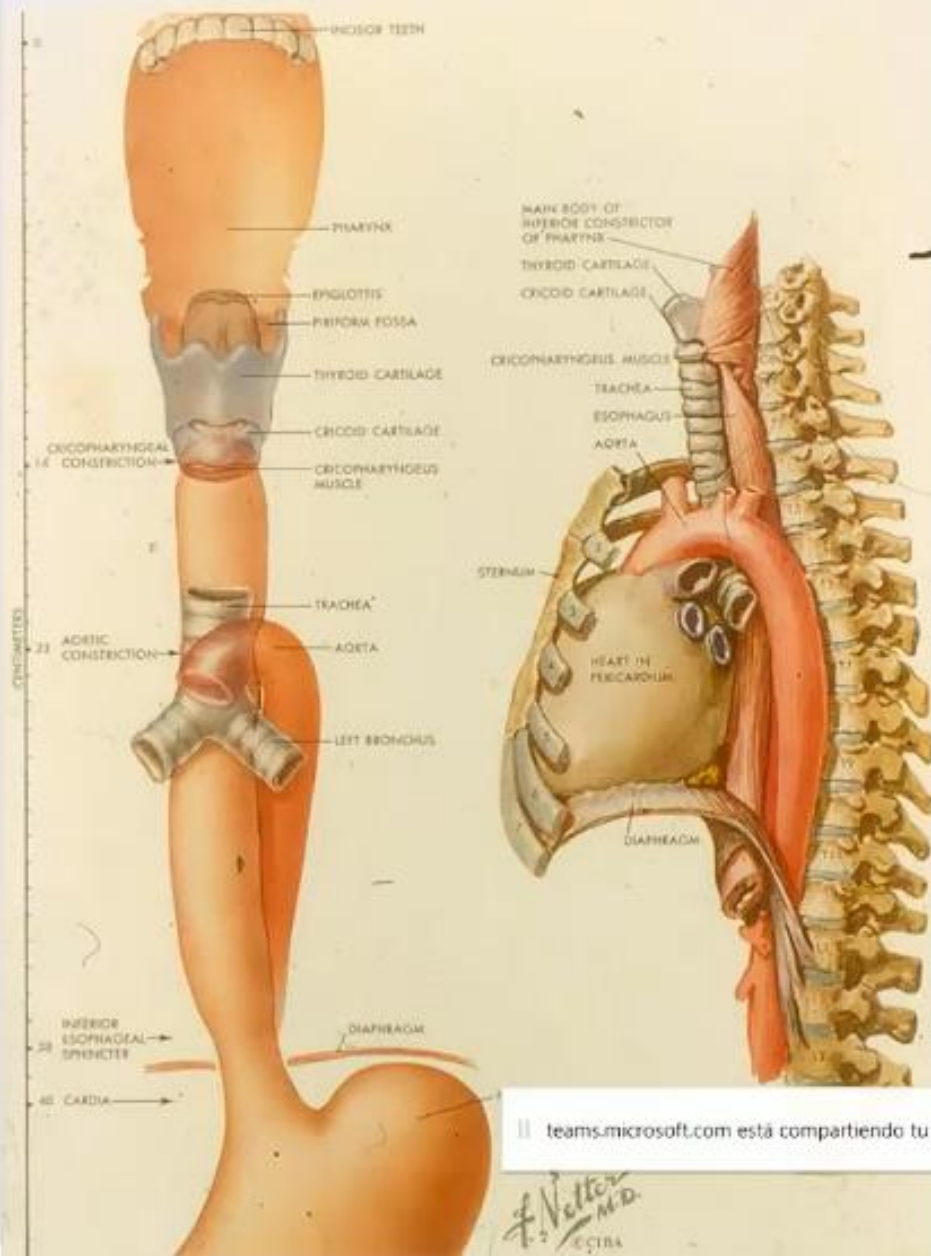
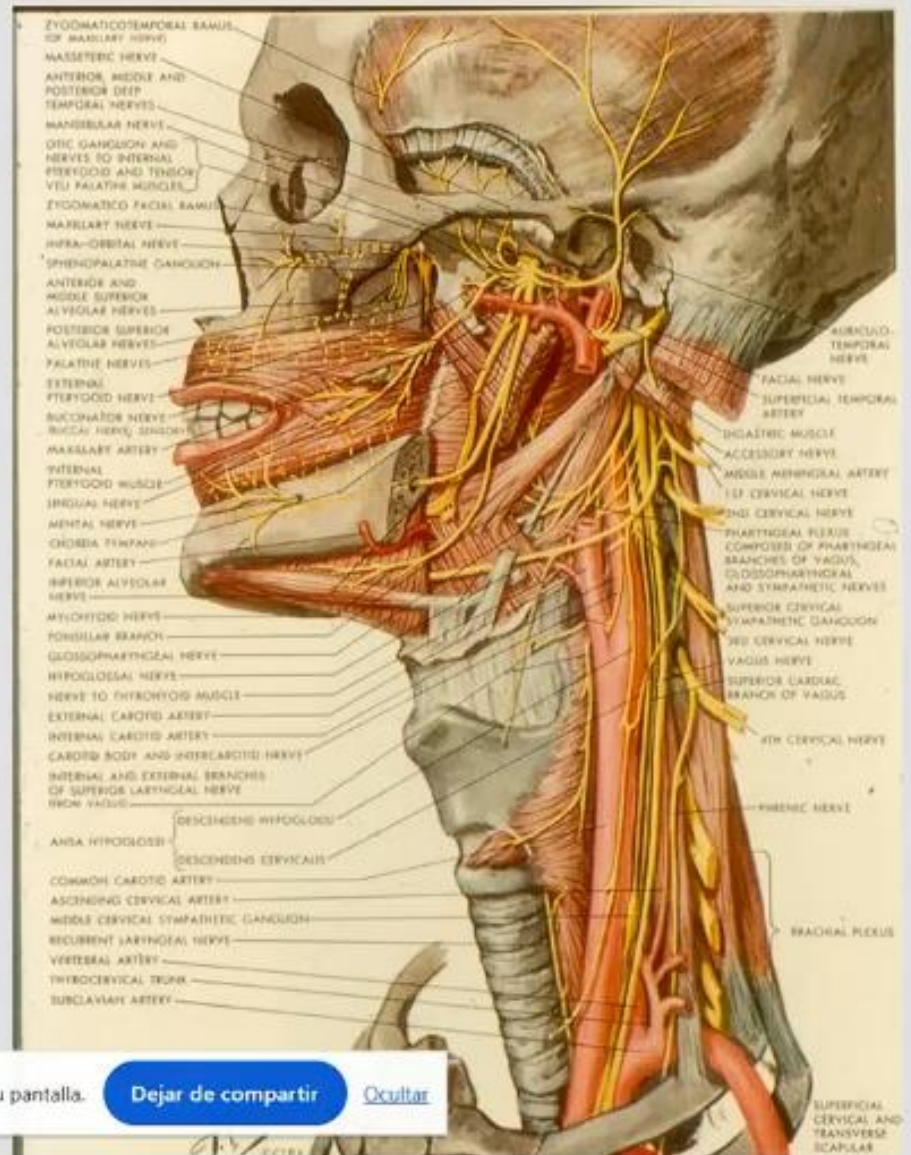
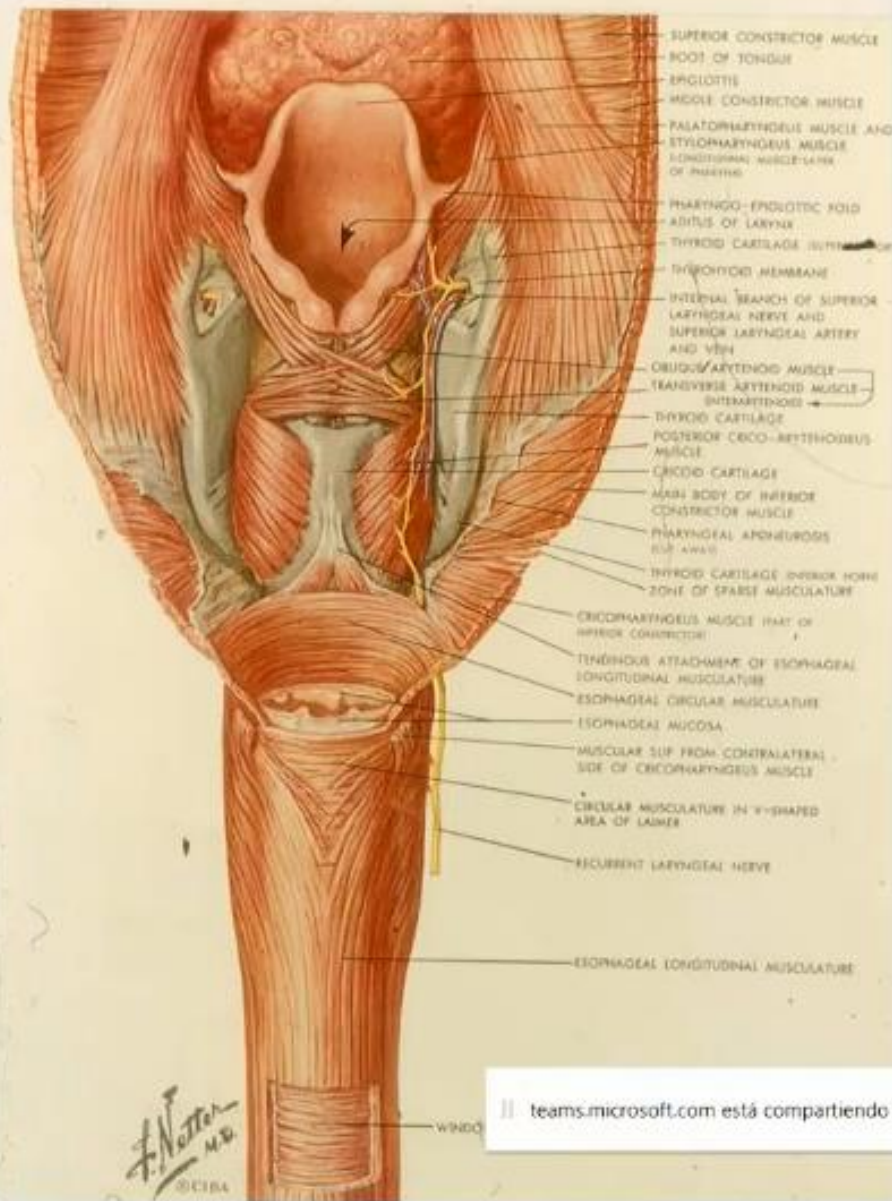


PATOLOGÍA QUIRURGICA DE ESÓFAGO

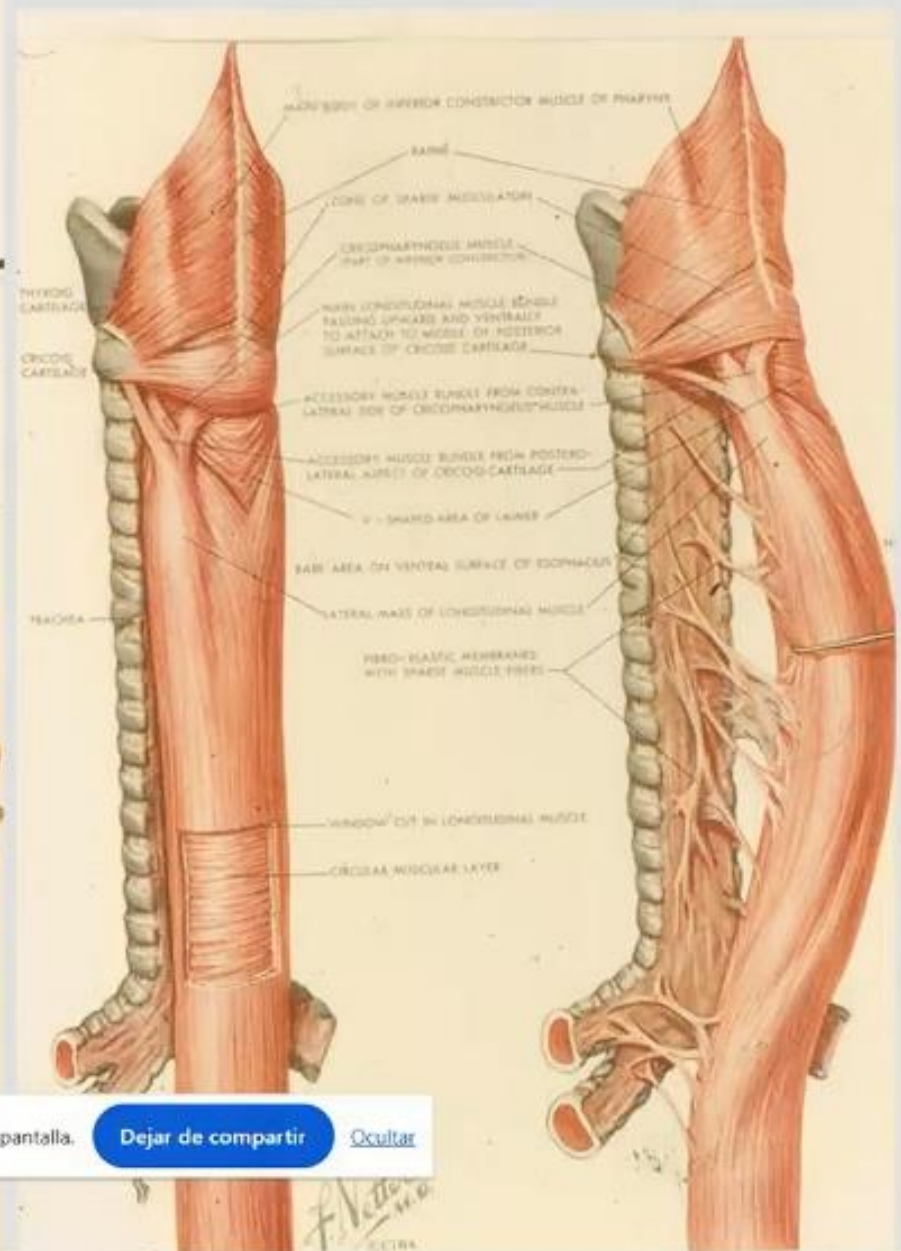
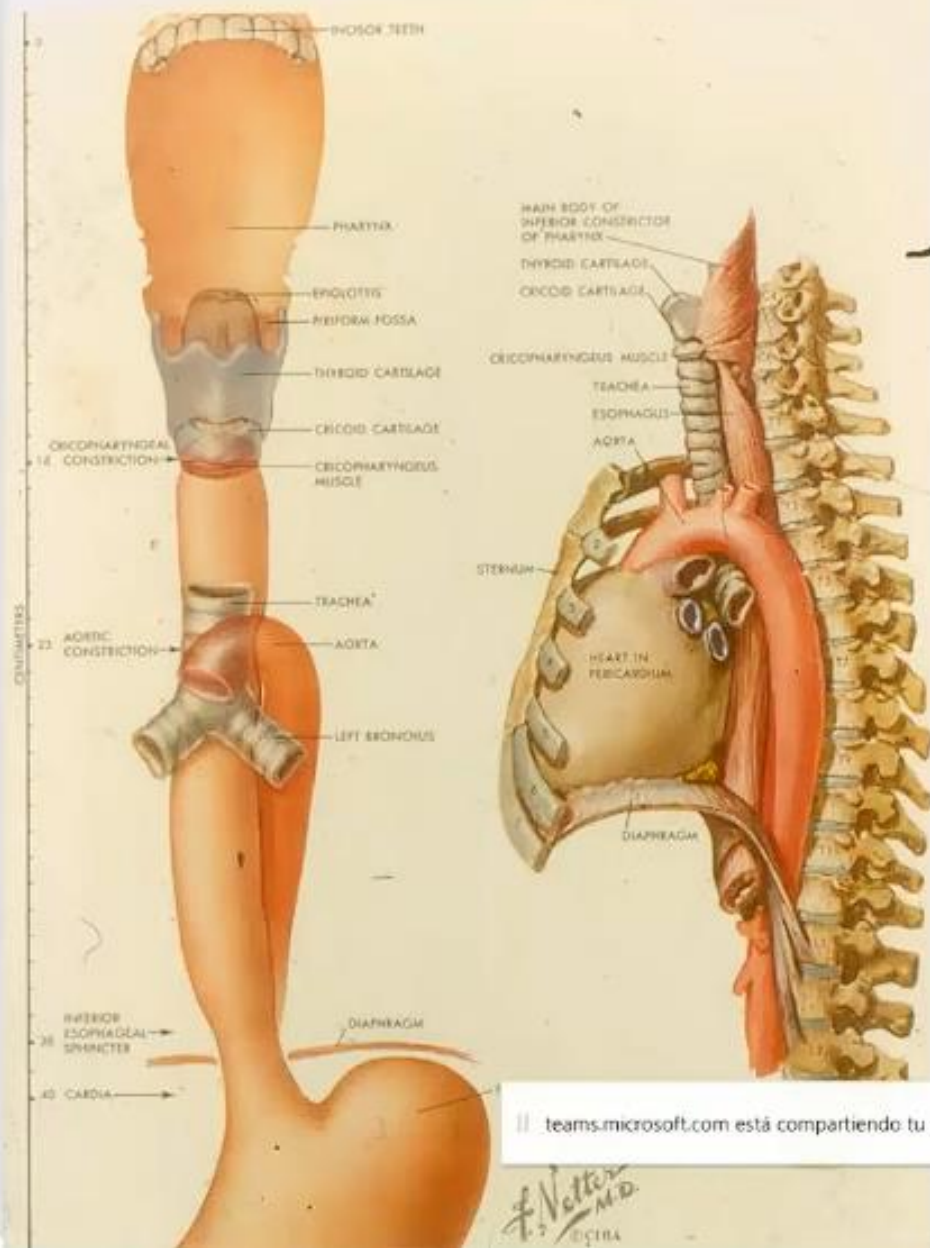
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL ESOFAGO



ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL ESOFAGO



ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL ESOFAGO

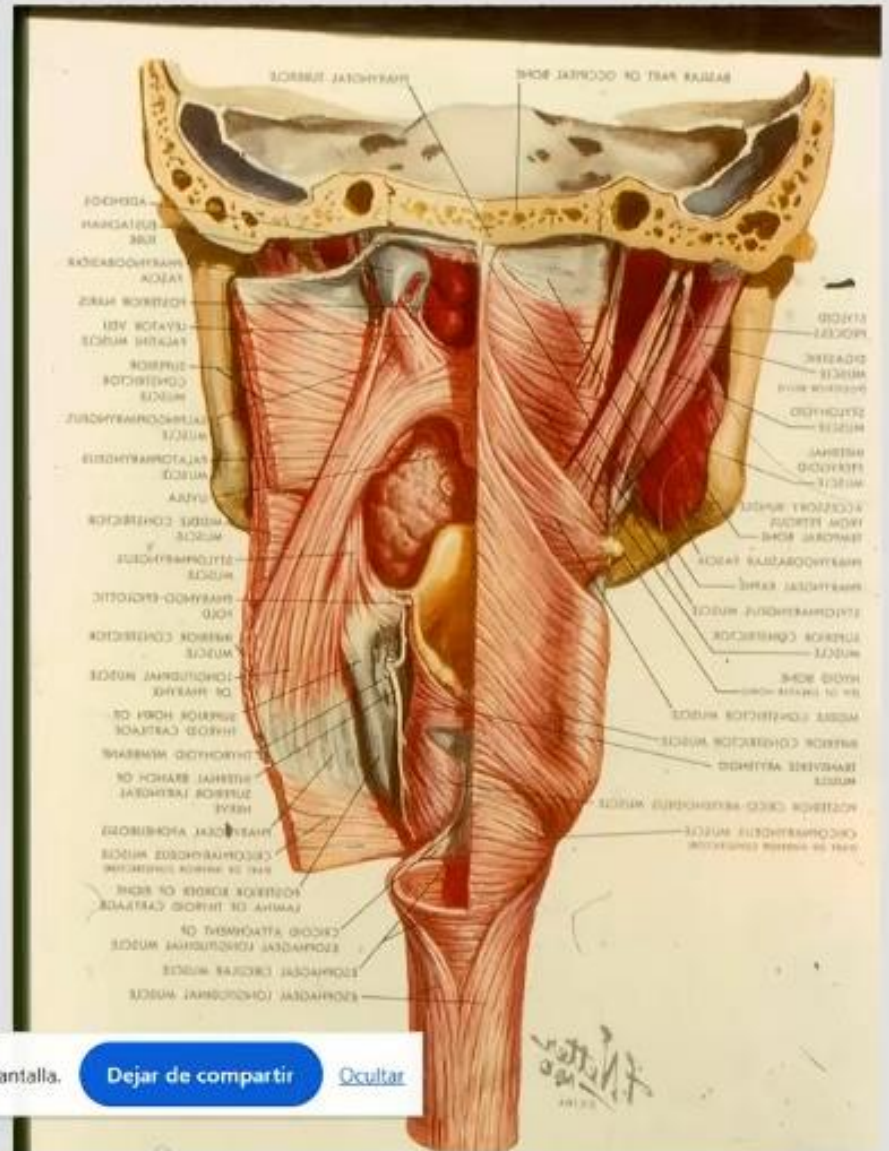
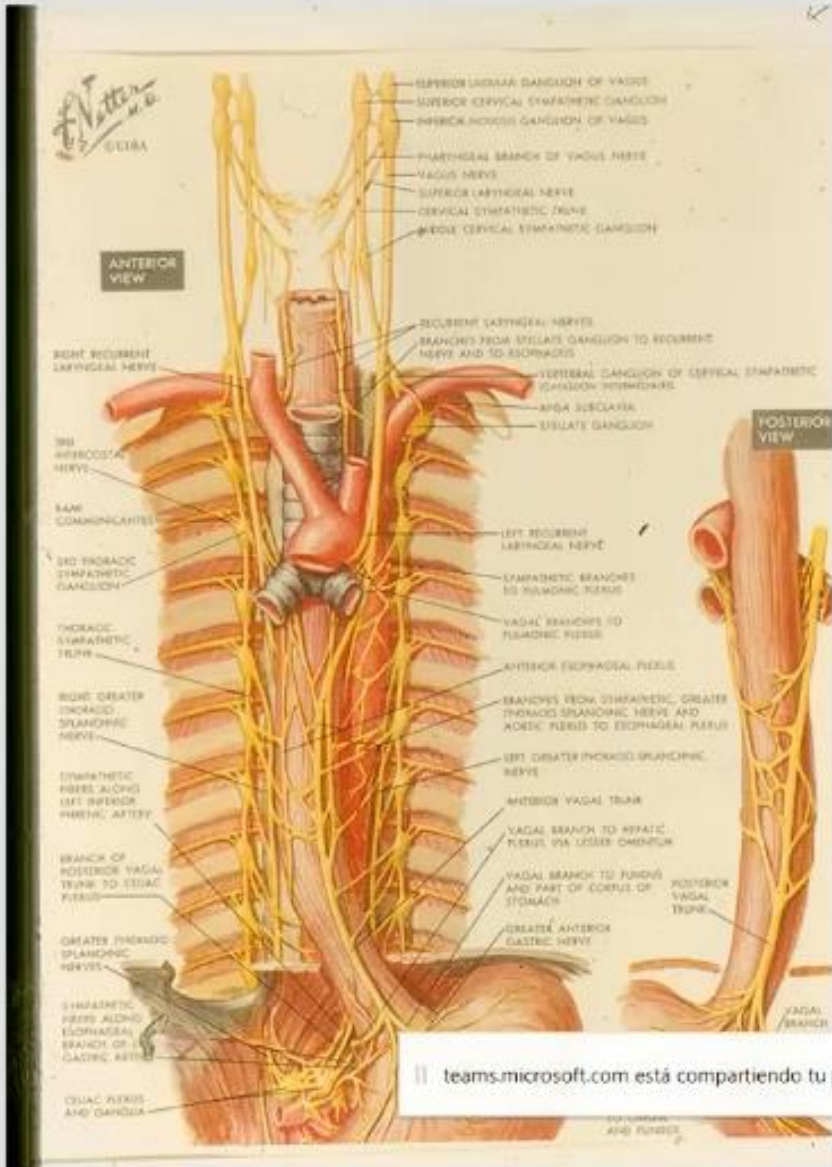


teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

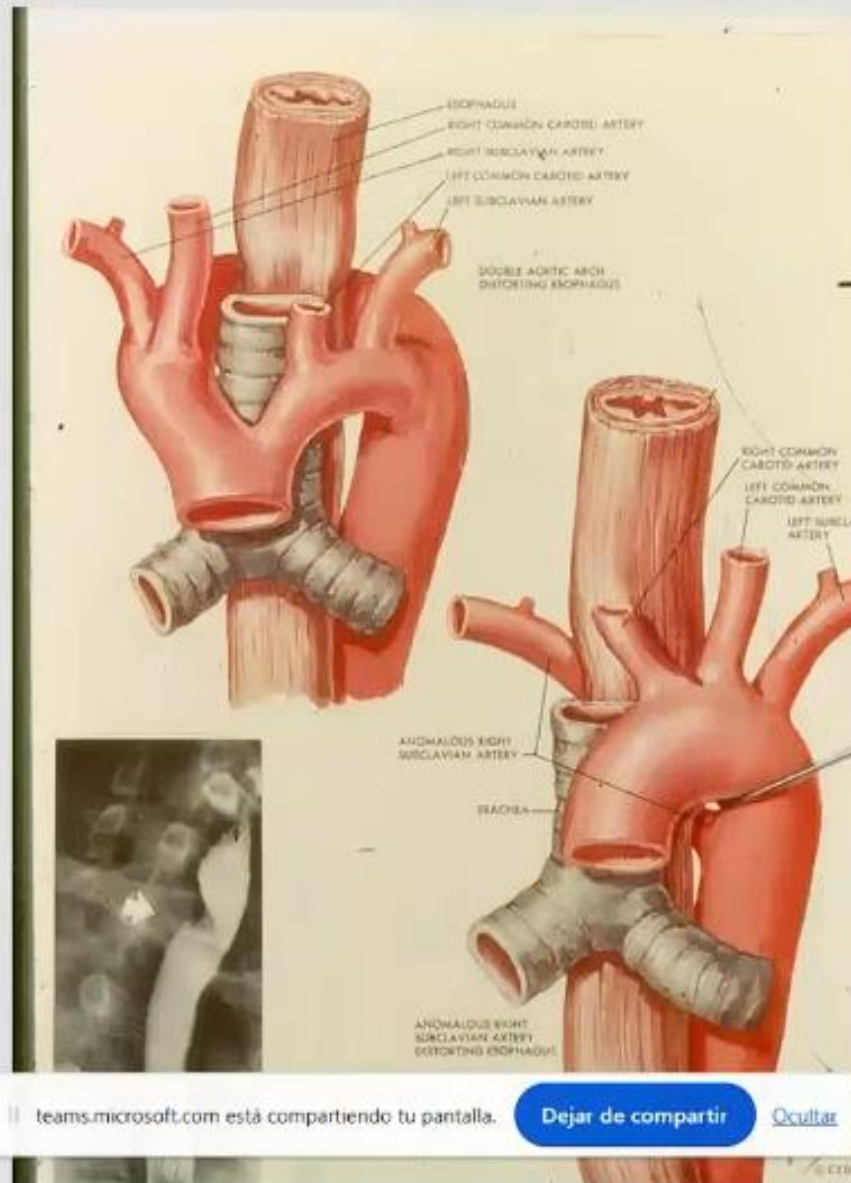
Dejar de compartir

Ocultar

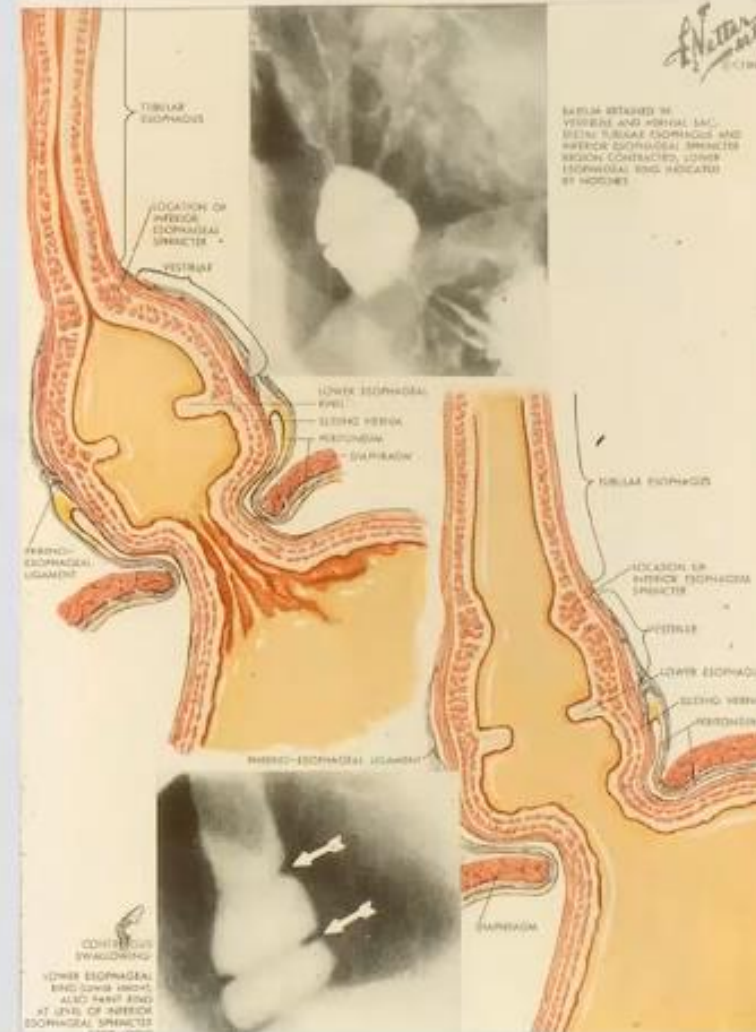
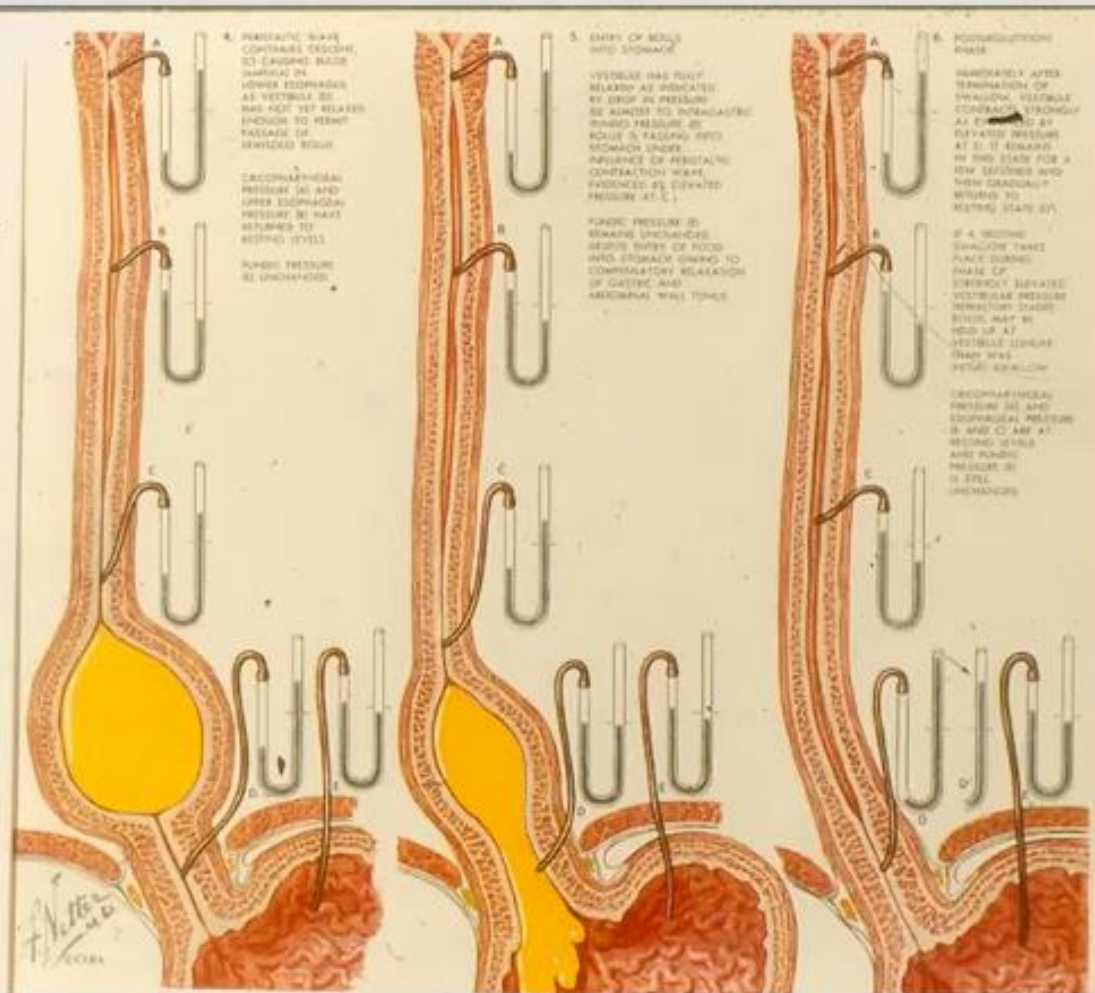
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL ESOFAGO



ANOMALÍAS CONGÉNITAS



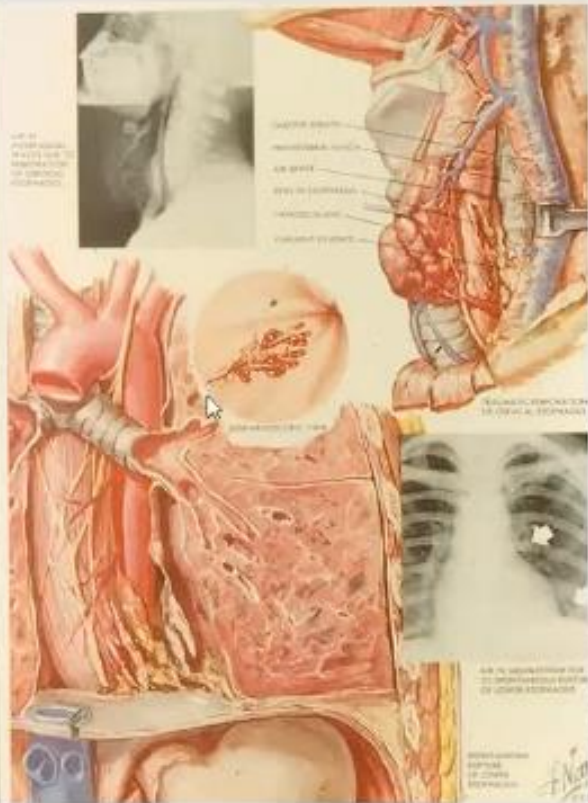
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA- MANOMETRÍA



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL ESÓFAGO



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL ESÓFAGO



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL ESÓFAGO



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA - EXÁMENES RADIOLOGÍCOS





DIVERTICULO DE ZENKER

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



PHARYNGO-ESOPHAGEAL
DIVERTICULUM
(ZENKER'S)



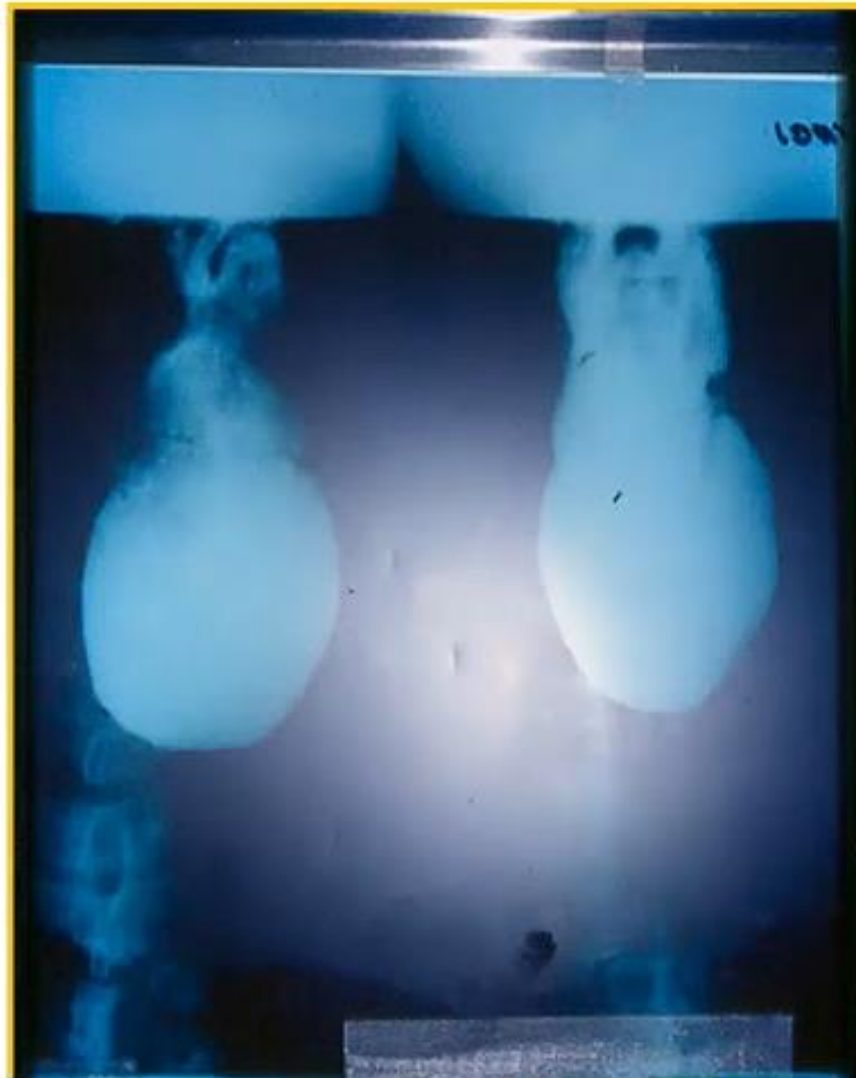
PHARYNGO-ESOPHAGEAL
DIVERTICULUM
(ESOPHAGOSCOPE VIEW)

TRACHEO-
DIVERTICULUM
(ESOPHAGOSCOPE
VIEW)



TRACHEO-
DIVERTICULUM
(ESOPHAGOSCOPE
VIEW)





|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

POSICIÓN DEL PACIENTE EN SALA DE OPERACIONES



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

Identificación del divertículo



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

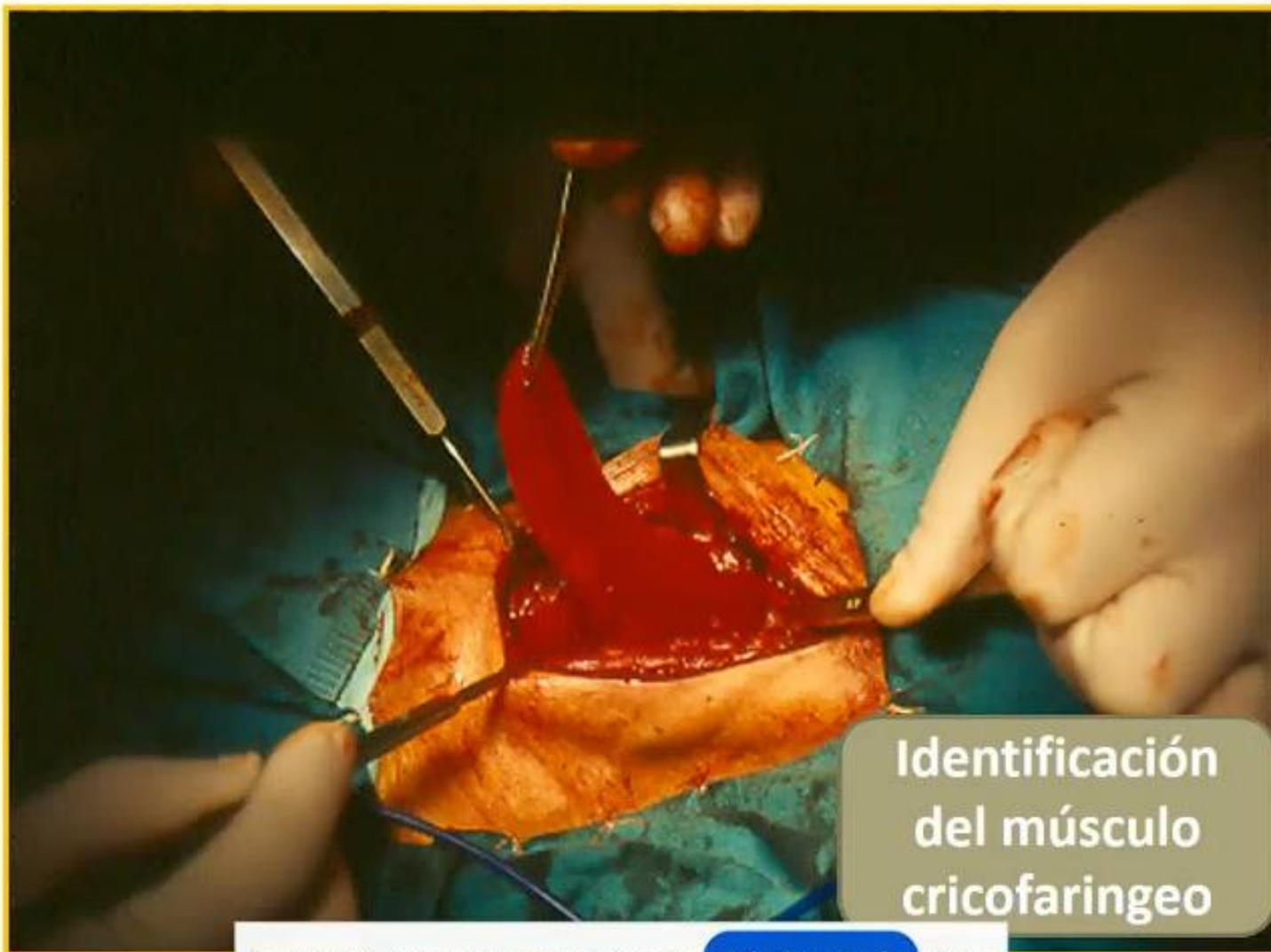
[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

**Identificación
del divertículo**



**Liberación del
divertículo**



**Identificación
del músculo
cricofaríngeo**

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



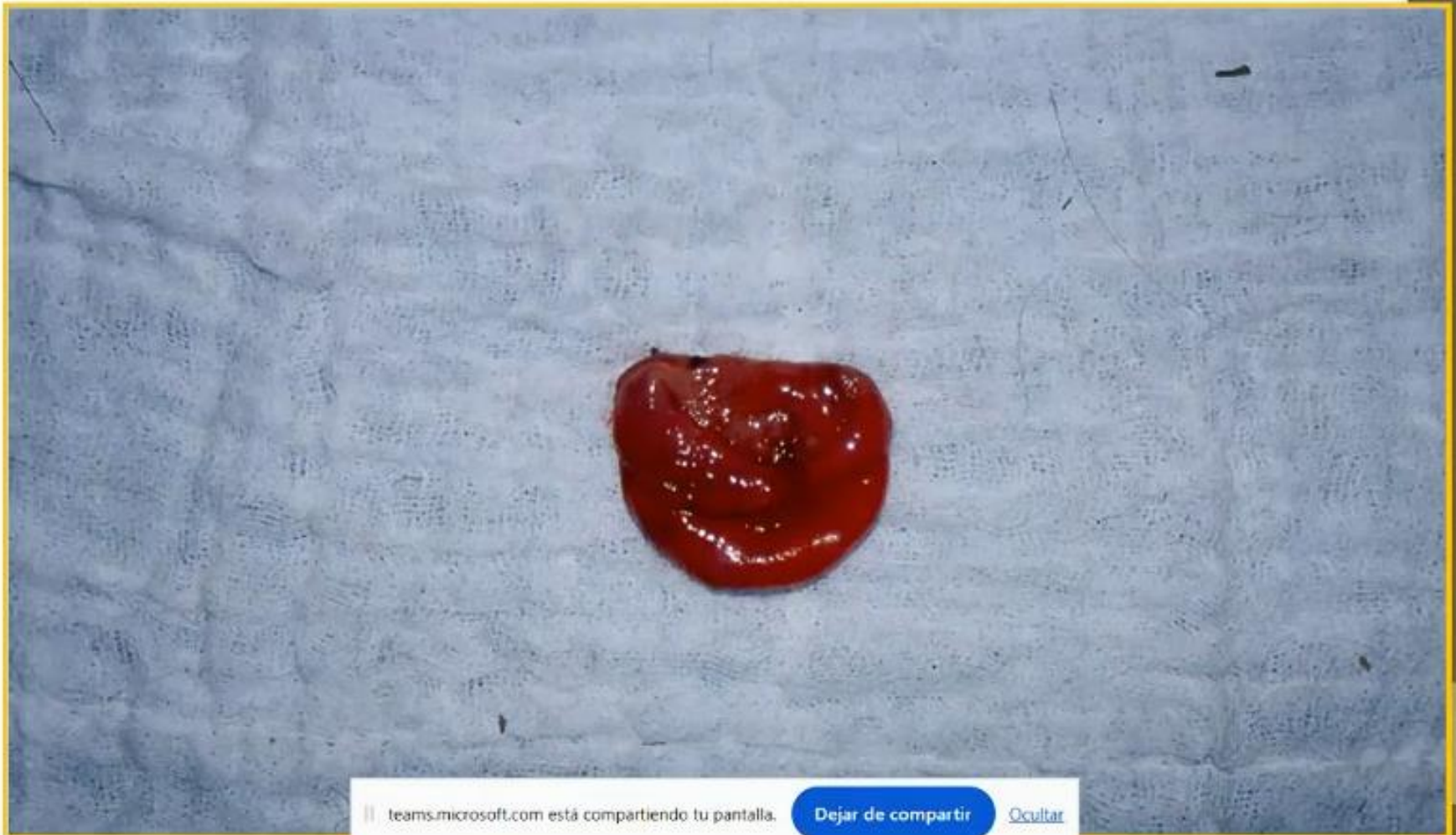
Sección del divertículo

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

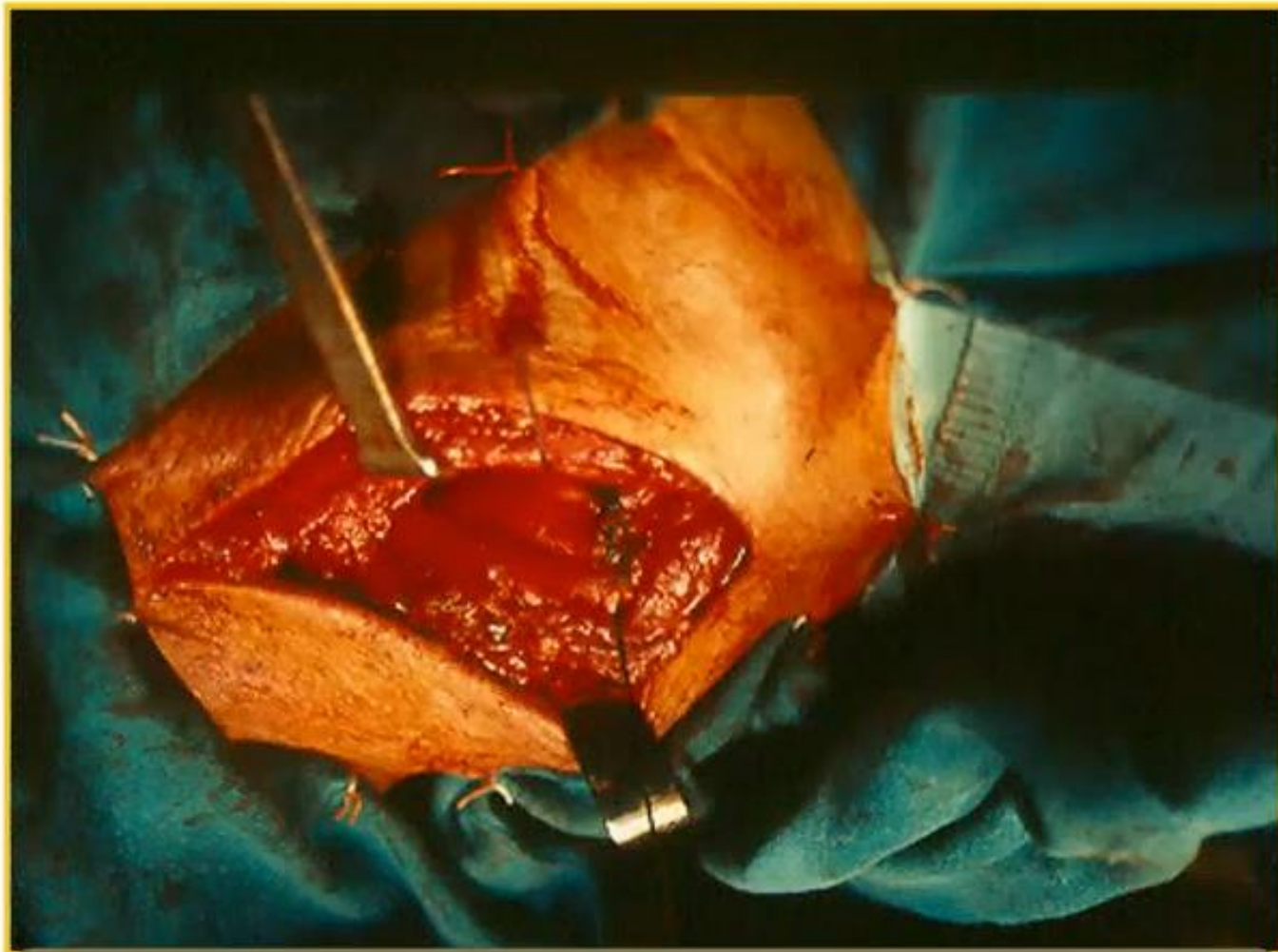
PIEZA OPERATORIA DEL DIVERTÍCULO



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



Sutura transversal forinocranial

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



**Cierre de herida operatoria por planos +
drenaje**

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

ACALASIA

ASPECTOS CLINICOS Y QUIRURGICOS

DEFINICION

- La acalasia de esófago corresponde al trastorno primario más común de la motilidad esofágica.
- Se caracteriza por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI) y la peristalsis del cuerpo esofágico durante la deglución, causada por la degeneración de los plexos nerviosos mientéricos y autónomo.

EPIDEMIOLOGIA

- La incidencia es de 0,5 a 1 por 100 000 en Estados Unidos.
- Se presenta en igual proporción en ambos sexos.
- La edad promedio en la cual inician los síntomas es 20 y 50 años, pero se puede presentar a cualquier edad.
- La prevalencia de 0,03 – 8 / 100 000, presentado una distribución bimodal.

ETIOLOGIA

ACALASIA PRIMARIA O IDIOPÁTICA

Es el resultado de una pérdida completa o ausencia relativa de células ganglionares inhibitorias del plexo mioentérico esofágico (Auerbach); esta pérdida crea un desbalance entre las neuronas excitatorias e inhibitorias que causa un fallo en la relajación del esfínter esofágico inferior.

Pérdida de neurotransmisores entre ellos el **óxido nítrico**, una de las principales sustancias encargadas de la relajación del músculo liso esofágico distal. ¹ *investigación.*

ACALASIA SECUNDARIA

- La causa mas frecuente es la enfermedad de Chagas, causada por la infección del protozooario *Trypanosoma cruzi*, el cual infecta las neuronas intramurales causando una disfunción autonómica.
- La *Pseudoacalasia* es el producto de la infiltración del esfínter esofágico inferior por cáncer o por una condición iatrogénica.

CUADRO CLINICO

- Disfagia lentamente progresiva para sólidos y líquidos, regurgitación de comida no digerida, dolor torácico, pérdida de peso.
- Los pacientes pueden tener historia sugestiva de aspiración incluyendo neumonías recurrentes y tos crónica.

DIAGNOSTICO

- Clínico
- La radiografía de tórax: puede sugerir el diagnóstico en casos avanzados por ausencia de burbuja gástrica y presencia niveles hidroaéreos en tórax y dilatación esofágica, que se observa de lado derecho posterior a la sombra mediastino.
- Esofagograma de bario: los cambios al inicio de la enfermedad son alteración de la peristasis distal asociado a un ligero estrechamiento de la unión gastroesofágica.

- El patrón radiológico típico de la acalasia da una apariencia de “**pico de pájaro o cola de rata**”, el cual se debe a la estrechez producida por el esfínter esofágico inferior distal a la columna de bario.
- **Fluoroscopia:** se observa pérdida de perístasis normal en los 2/3 inferior esófago, mientras que el extremo distal presenta un estrechamiento persistente correspondiente al esfínter inferior contraído.

- **Manometría Esofágica:** es el **estandar de oro** para el diagnóstico de la *acalasia*, representa la prueba diagnóstica más sensible disponible.
- El cuerpo del esófago muestra una elevada presión de reposo como respuesta a la deglución.

CARACTERISTICAS MANOMETRICAS EN ACALASIA

- Hipertensión de esfínter esofágico inferior (50% de los pacientes)
- Incompetencia o no relajación del esfínter esofágico inferior
- Aperistalsis del cuerpo esofágico
- Presurización esofágica: elevación de la presión de base del esfínter esofágico inferior.

ACALASIA

TRATAMIENTO

I.- TRATAMIENTO MEDICO

- *Nitratos e inhibidores de los canales de calcio*
- *Toxina botulínica: su eficacia en un corto periodo (6 meses)*
- *Dilatación con balón.*

ETAPA EVOLUTIVA DE LA ENFERMEDAD DE **ETAPAS EVOLUTIVAS** REZENDE:

- 1.-**Hiperactividad e hipertrofia de la capa circular del esófago:** No hay contracciones con secuencia peristáltica. Aún no hay dilatación esofágica. Ondas de contracción no sincronizadas en la manometría.
- 2.-**Moderada:** dilatación esofágica entre 4-6 cm. Se pierde la capacidad de contracción del músculo esofágico.
- 3.-**Severa:** la dilatación es mayor a los 6 cm. El esófago ya no se contrae y puede adquirir un aspecto tortuoso.

ETAPA EVOLUTIVA DE LA ENFERMEDAD DE ACUERDO A LA ESTADIFICACIÓN DE REZENDE:

- **Grado 1** - forma inicial con cuerpo esofágico con diámetro menor a 4 cm.
- **Grado 2** – esófago dilatado con diámetro entre 4-7 cm.
- **Grado 3** - diámetro esofágico entre 7-10 cm.
- **Grado 4** – diámetro mayor a 10 cm. puede observarse eje sinuoso, dolicoesófago.

Reza
ap

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

clínico-radiológicos de
aterol. 1985;12:247-257.

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ACALASIA

1.- CARDIOMIECTOMIA MÁS FUNDOPLICATURA



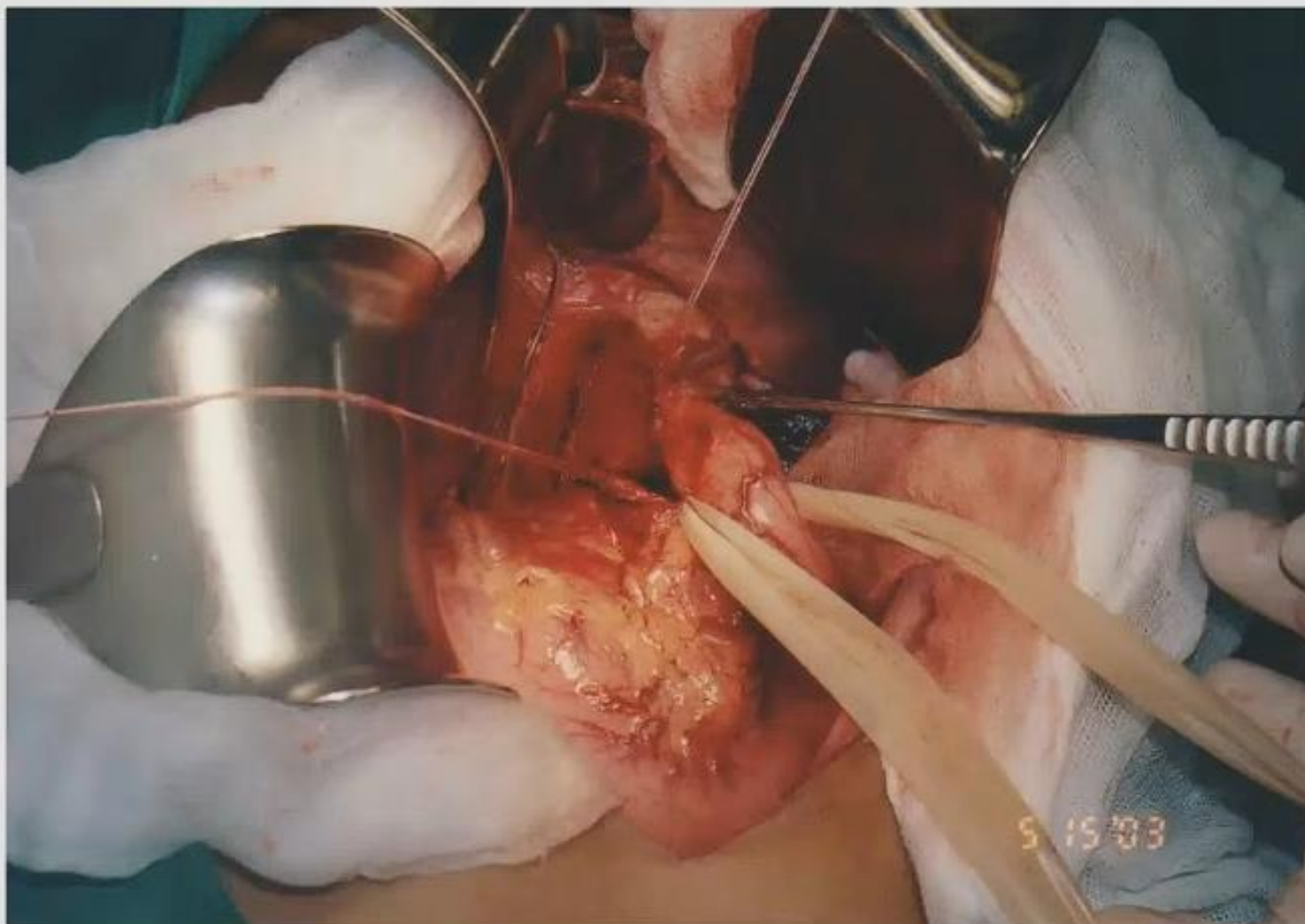
LIBERAC

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

ISTAL



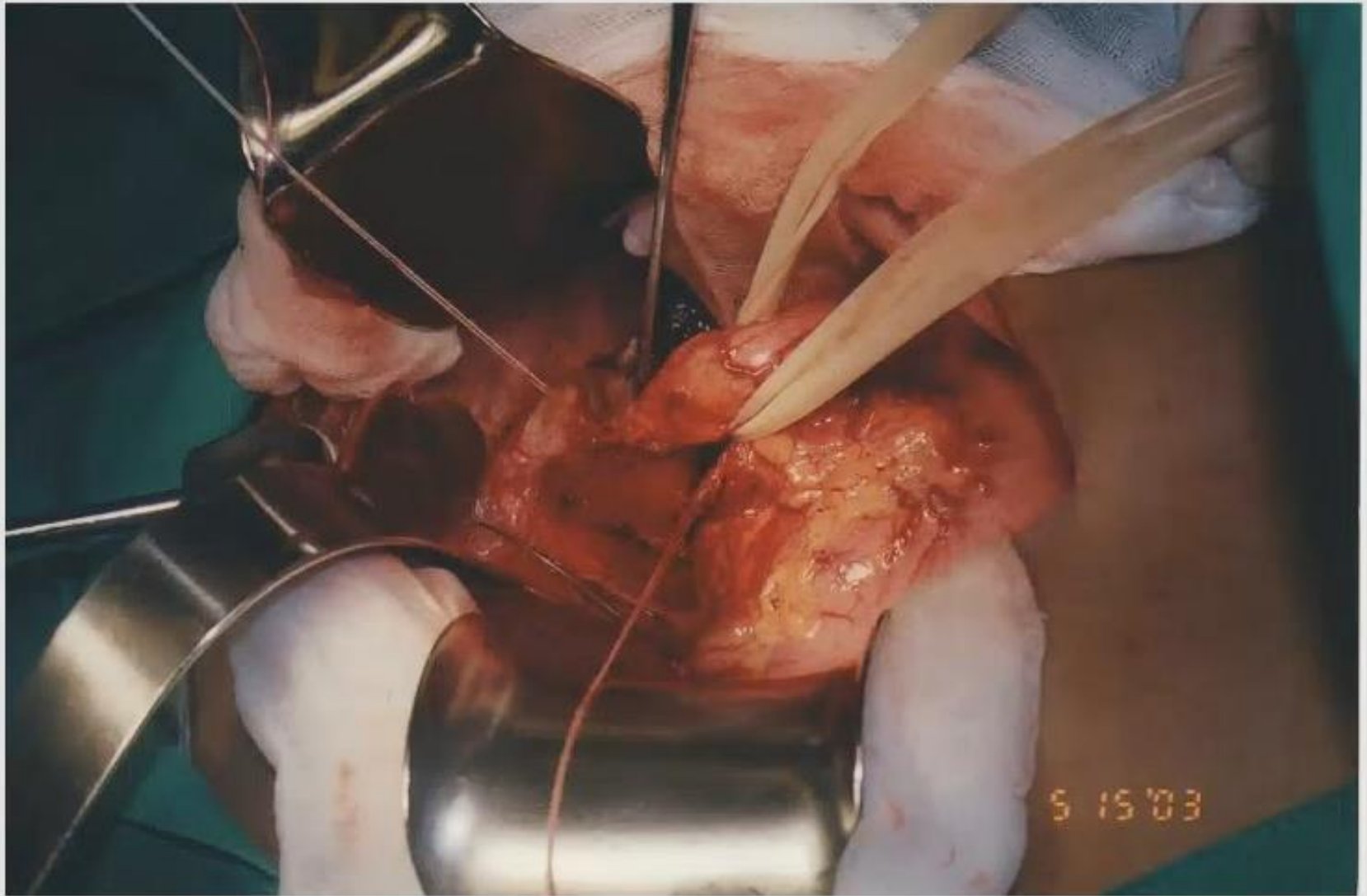
IDENT

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

OS



ESTE

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

AL



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

LIGADURA Y SECCION DE VASOS CORTOS



APLICACIÓN DE TÉCNICA ORTODONTICA

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



IDENTIFICAR

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

CARDIAS

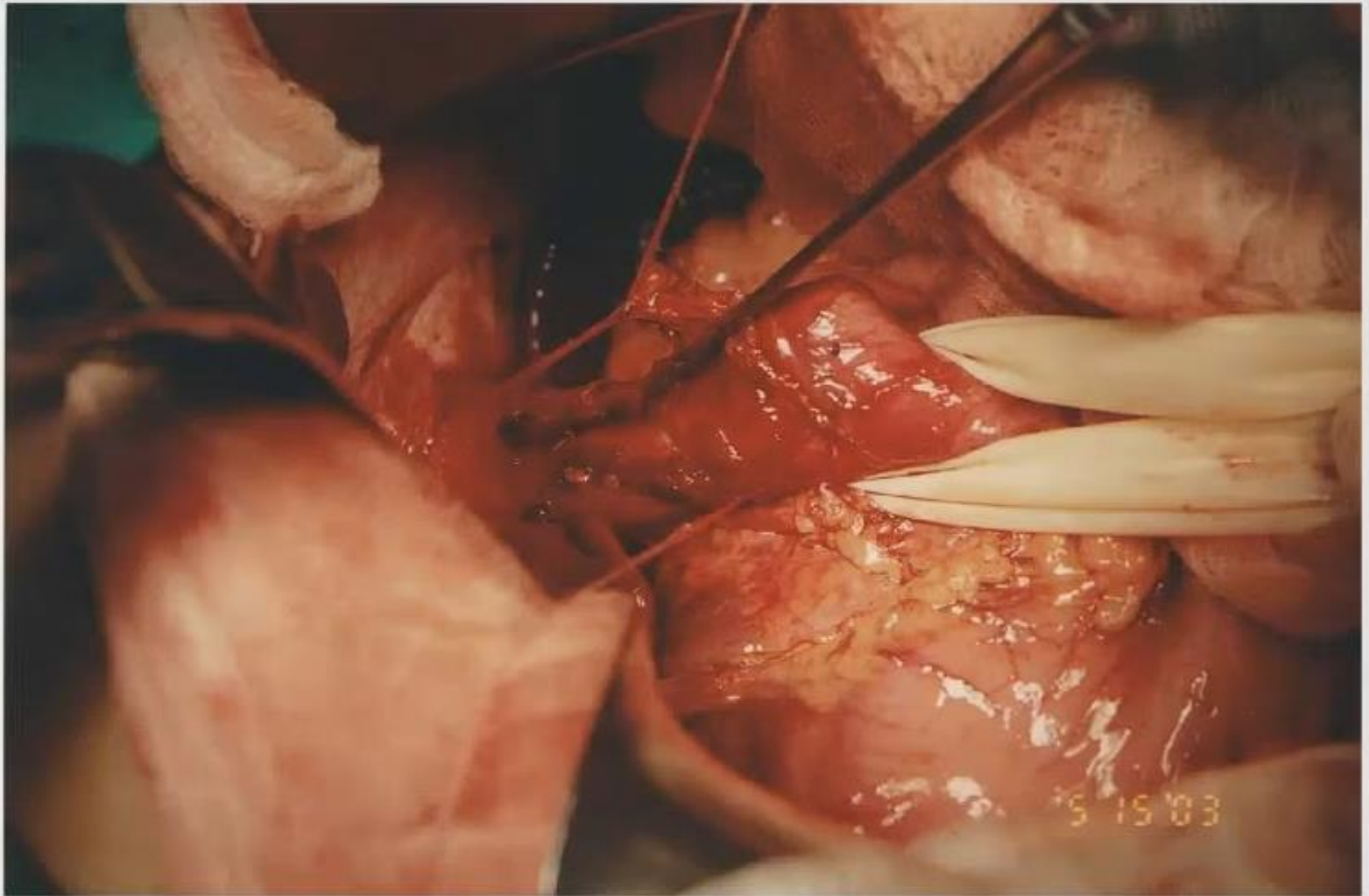


IDENTIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS DE LA UNIÓN
ESOFAGOGÁSTRICA

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

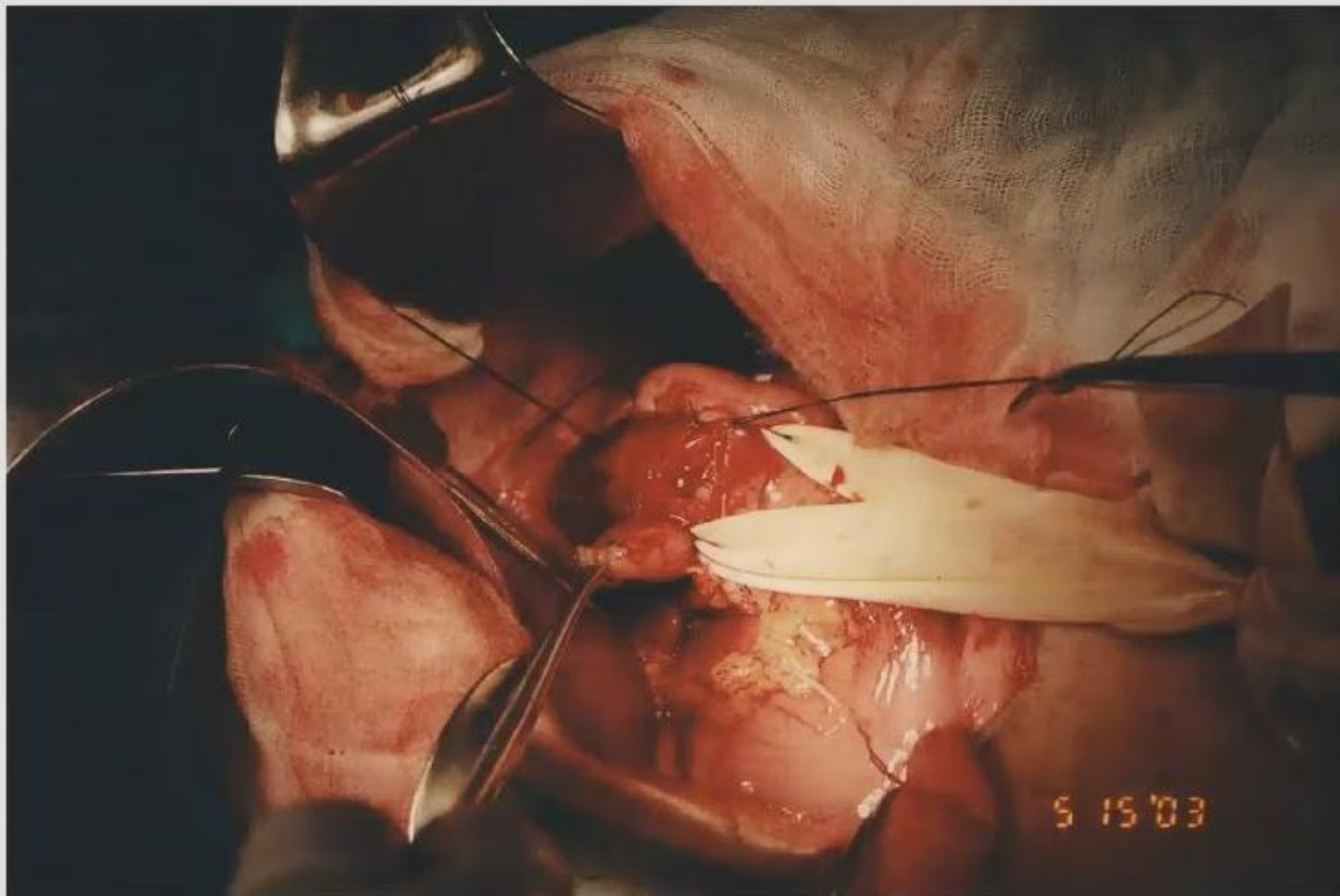


teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

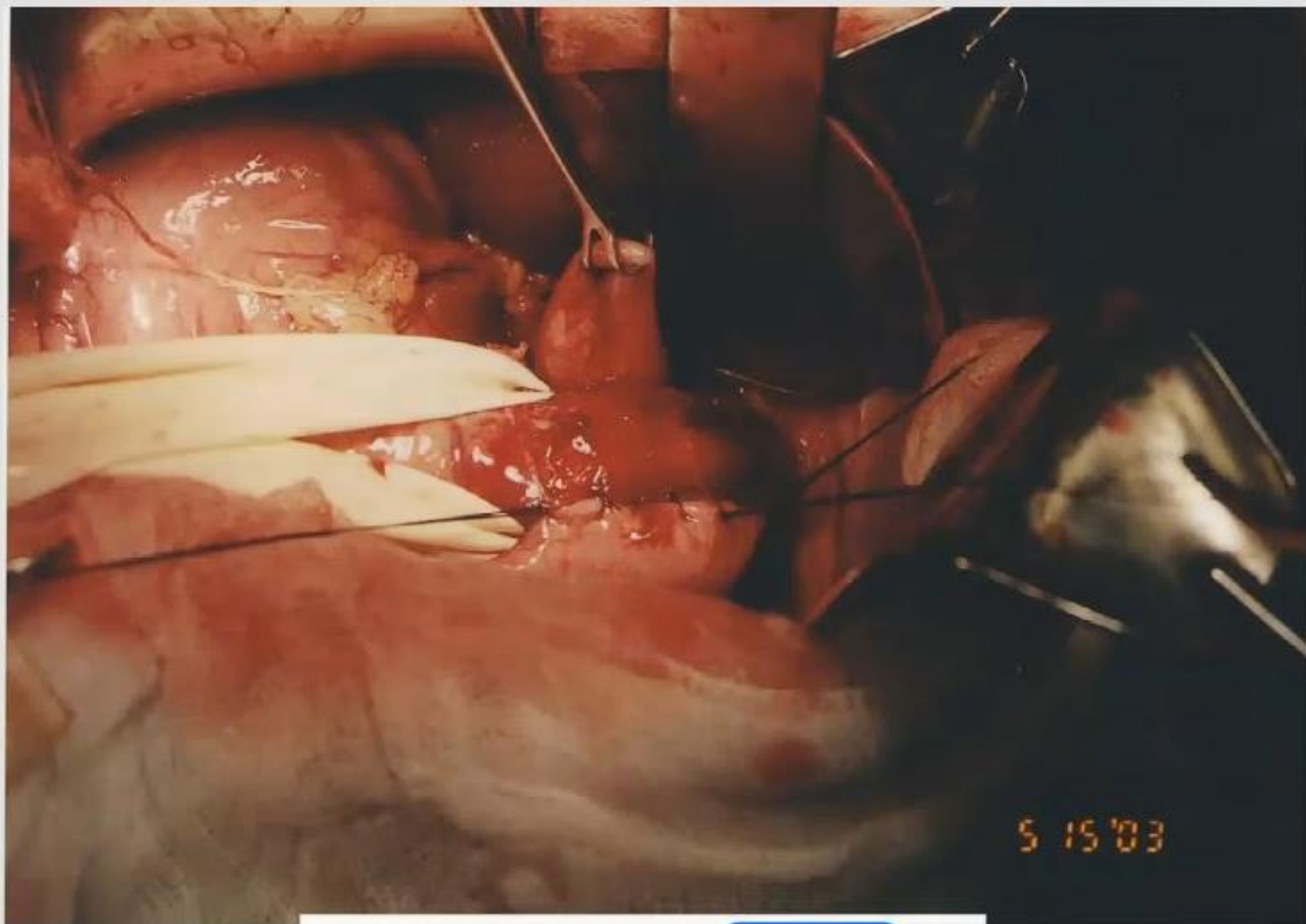
OMIA



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

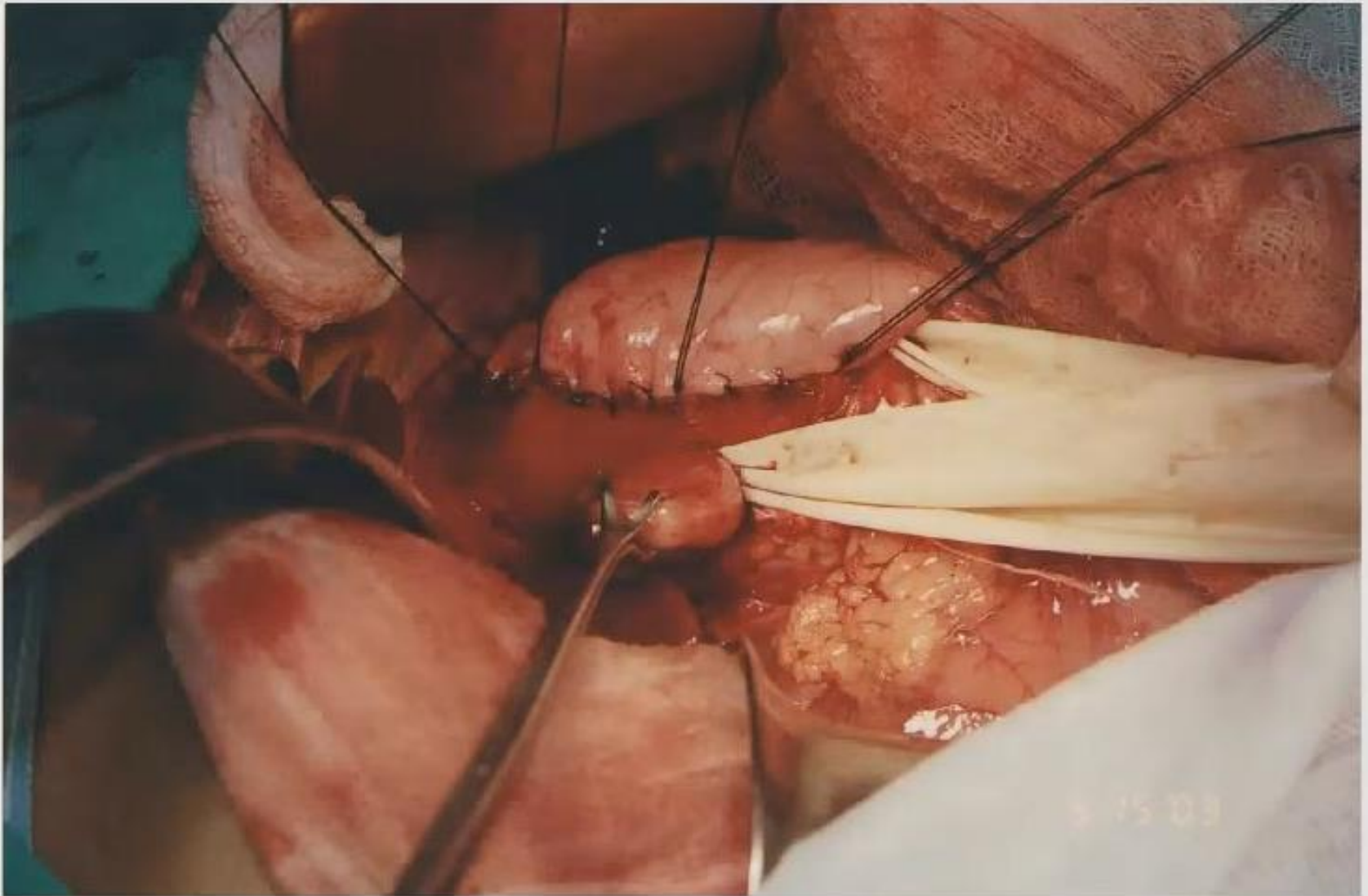


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

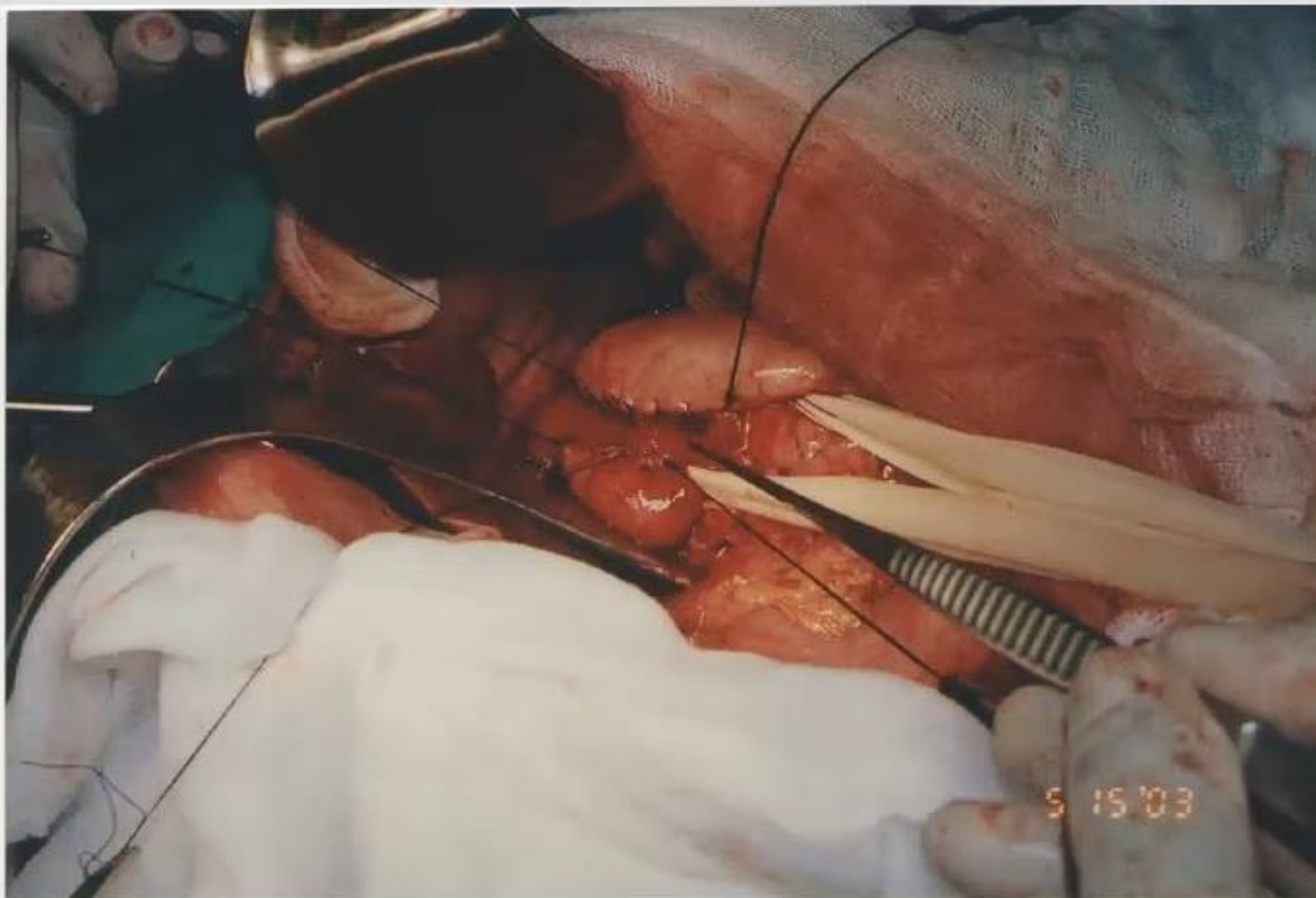
COLOCACIÓN DE TORNILLOS EN FONDO DE LA CAVIDAD



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



PUNTOS D

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

CATURA

2.- ESOFAGUECTOMÍA TRANSDIAFRAGMÁTICA, TRANSMEDIASTINICA POSTERIOR, ESOFAGOGASTROPLASTIA CERVICAL



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

GRADO IV DE ACALASIA. MEGAESOFAGO



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

POSICION QUIRURGICA DEL PACIENTE



Esofagueo

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

mediastinica



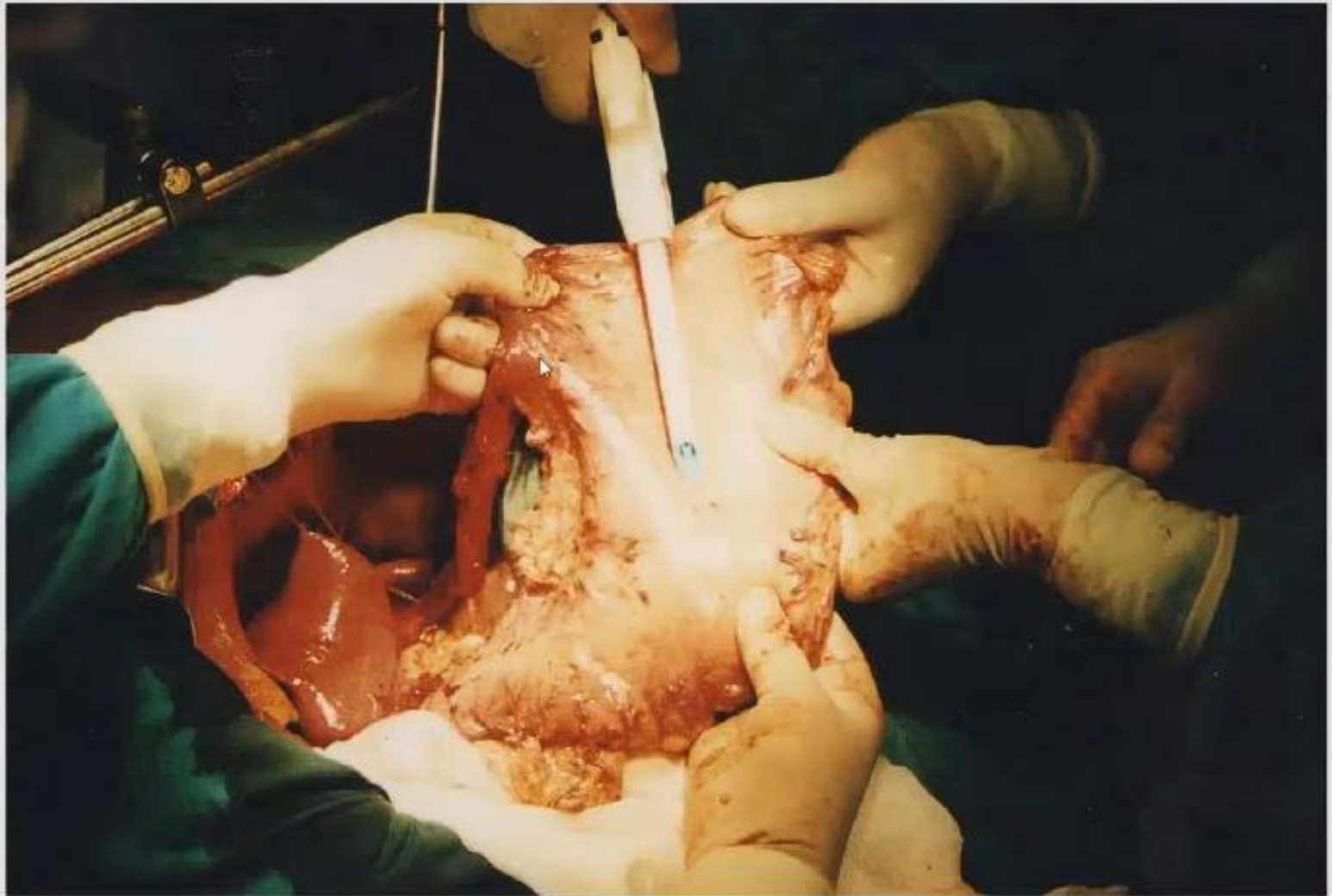
ESO

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

FRAGMÁTICA



Formaci

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

Automática

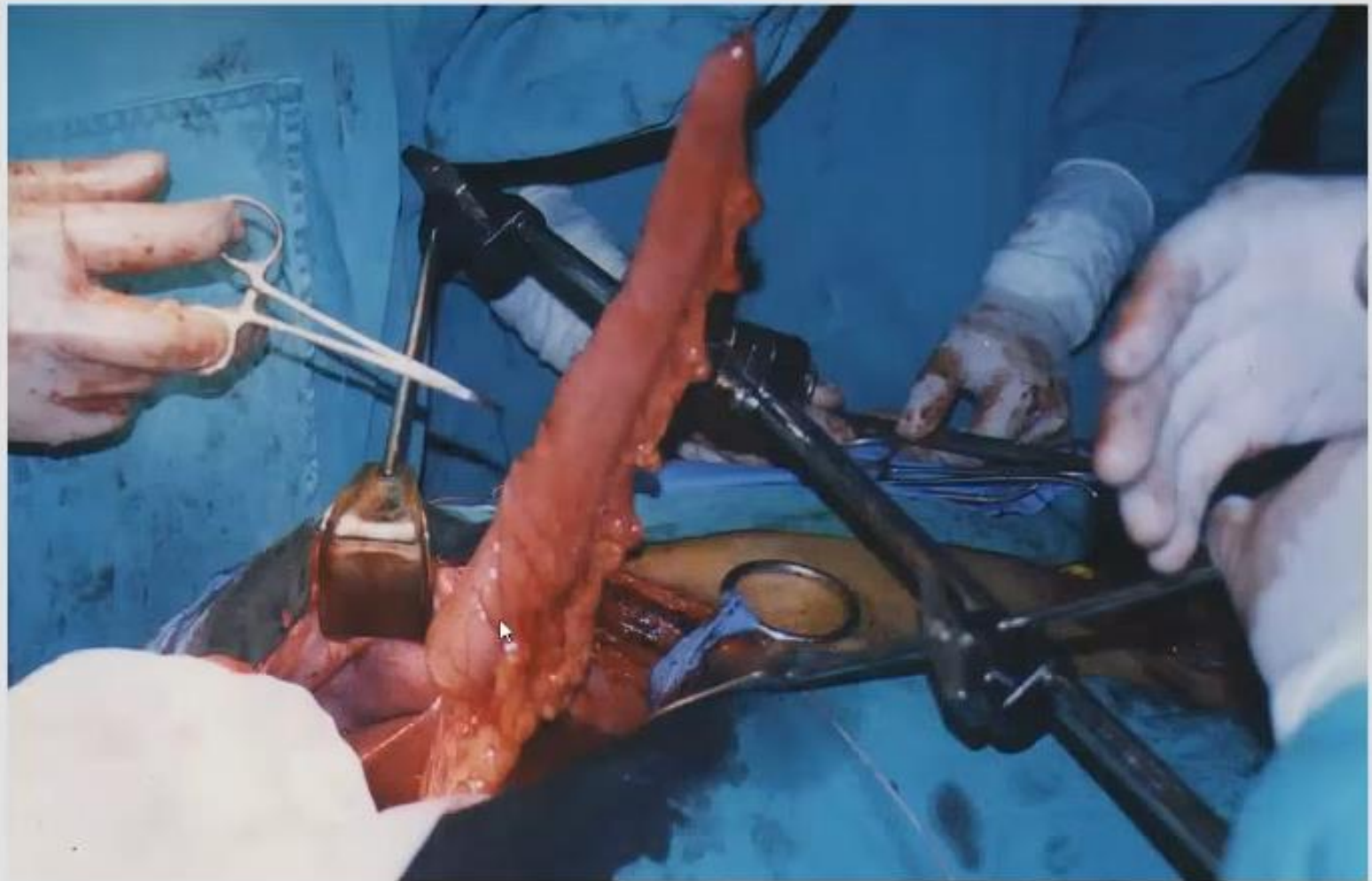


For teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

poner

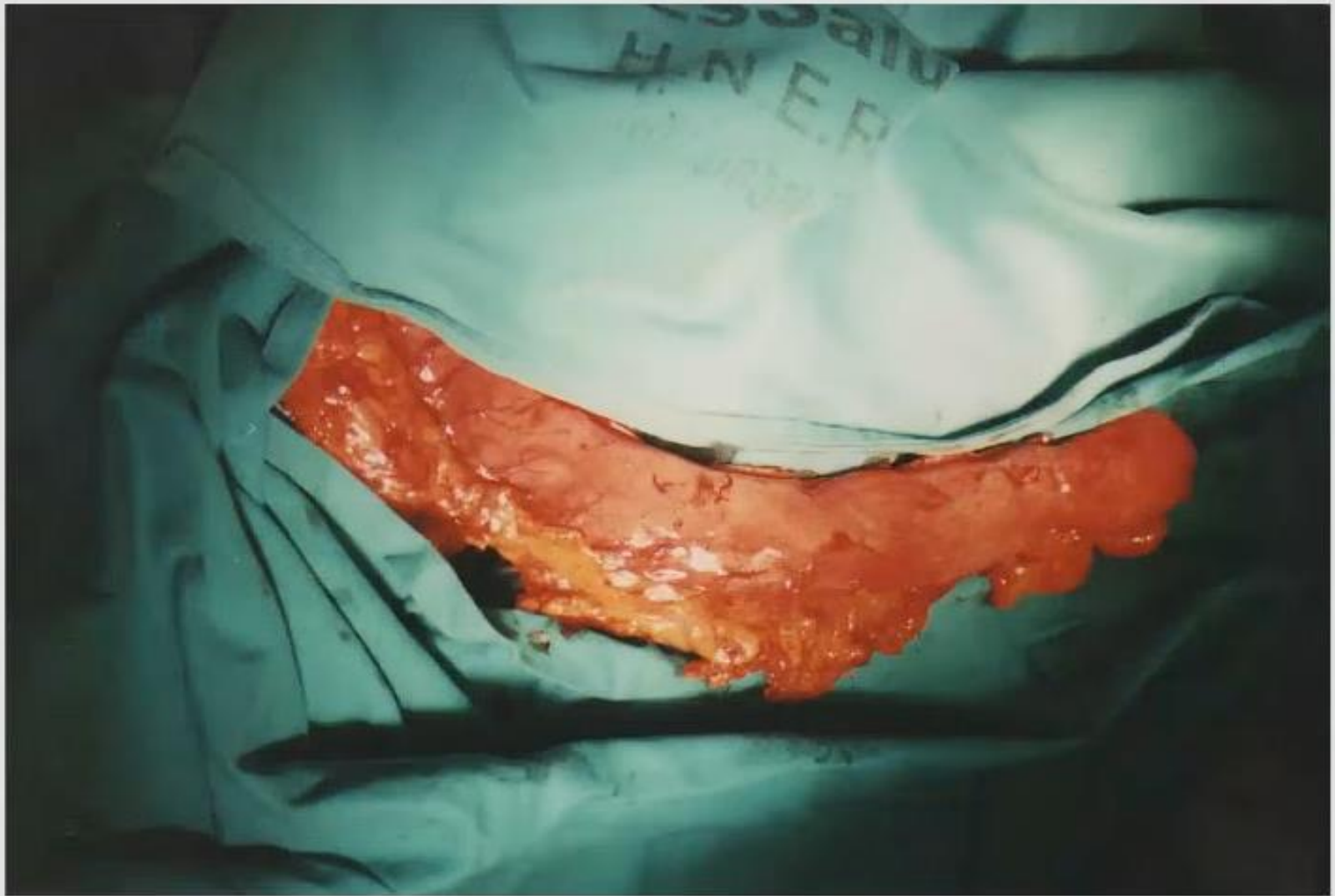


Tubo gástrico completo para transpor por vía

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



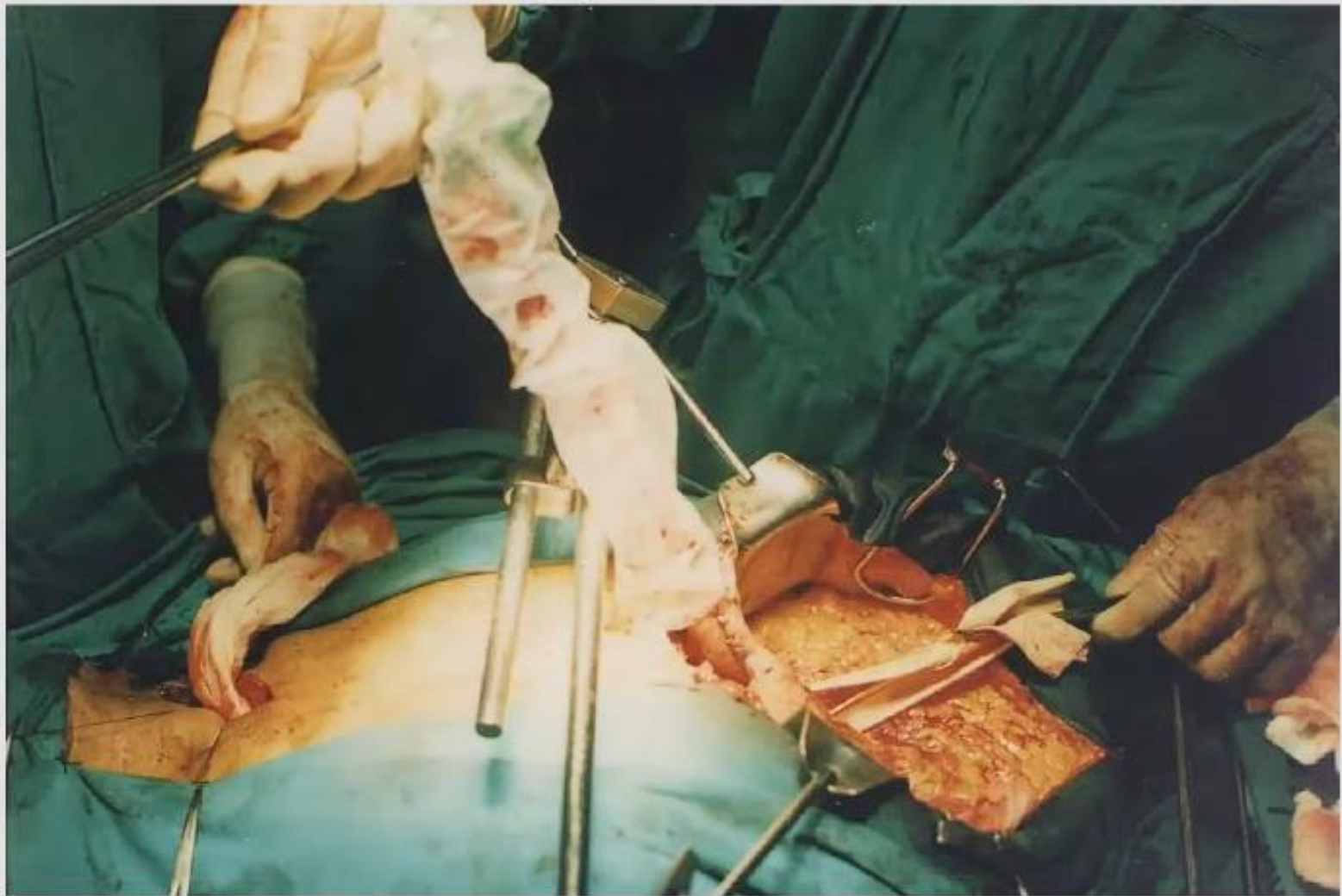
Tubo g

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

osición



Bolsa

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

insponer



Bolsa protectora c... se por mediastino
posterior

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

rda



Identificación de esófago cervical

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

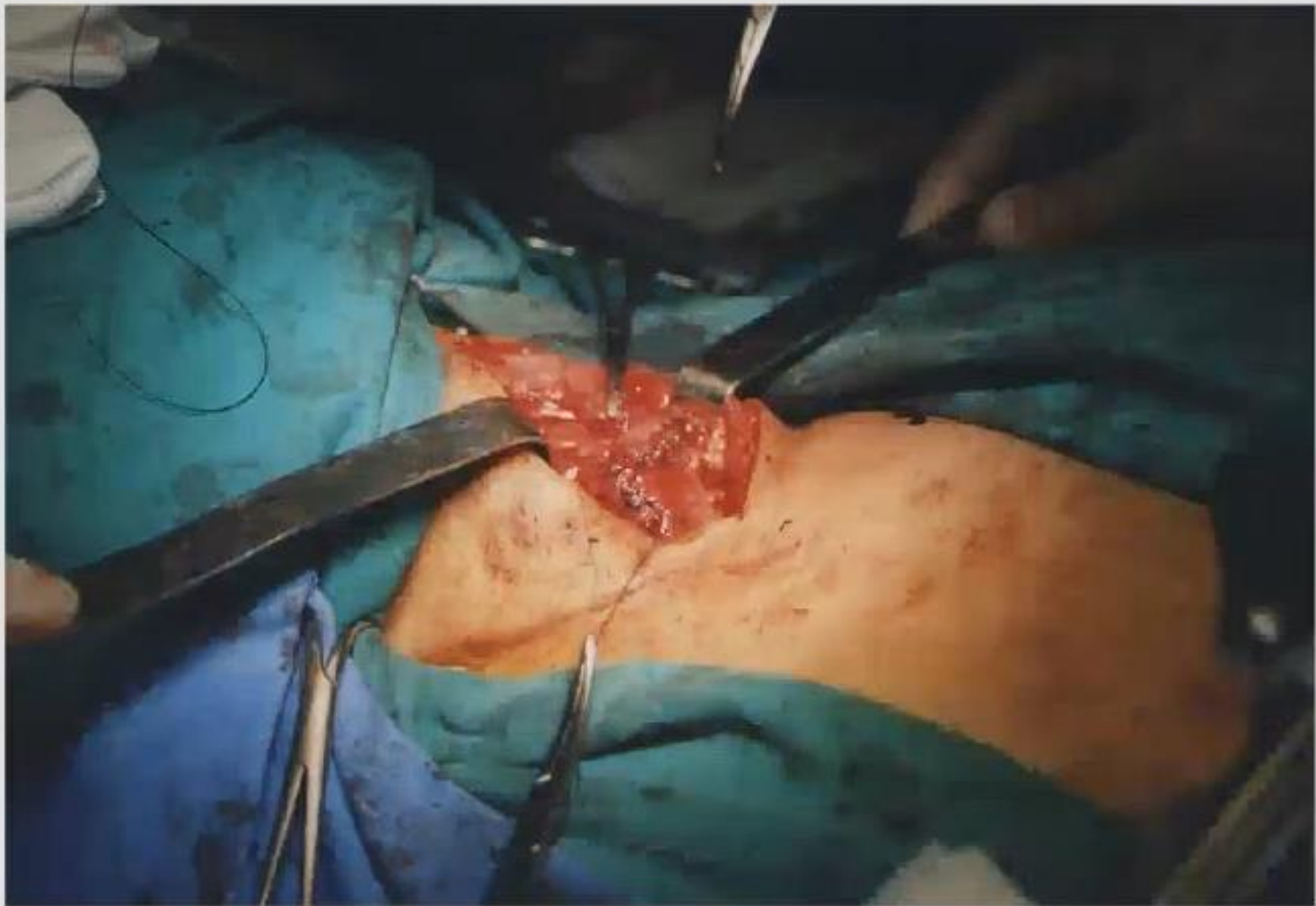


Transposición de tubo gástrico con bolsa protectora a nivel cervical

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



Anastomosis

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

ino-terminal



POSOPERADA: ESOFAGUECTOMIA-TRANSPOSICIÓN
OSTOMIA

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



Esofaguectomía con gastrectomía proximal. Megaesófago



Este

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

ago

PERFORACION DE ESOFAGO

Dr. Jáuregui Francia Filomeno

Lima - Perú

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

PERFORACION DE ESOFAGO

- SOLUCION DE CONTINUIDAD
DE TODAS LAS PAREDES DEL
ESOFAGO

PERFORACION DE ESOFAGO

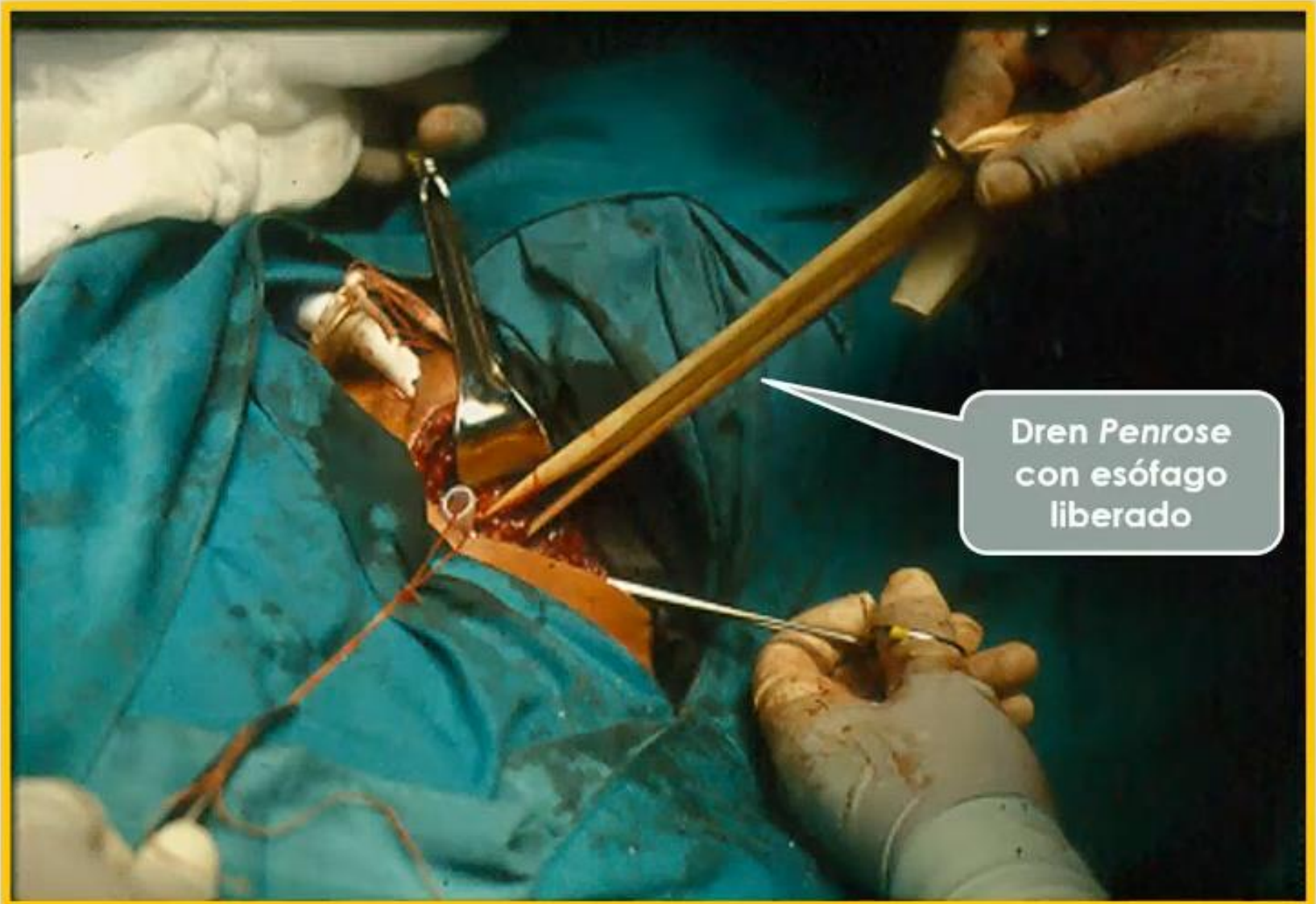
TRATAMIENTO

- LUGAR DE LA LESION
- DIAGNOSTICO TEMPRANO O TARDIO
- GRAVEDAD DEL CUADRO
- PATOLOGIA ESOFAGICA ASOCIADA.



PERFORACIÓN DE ESÓFAGO

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



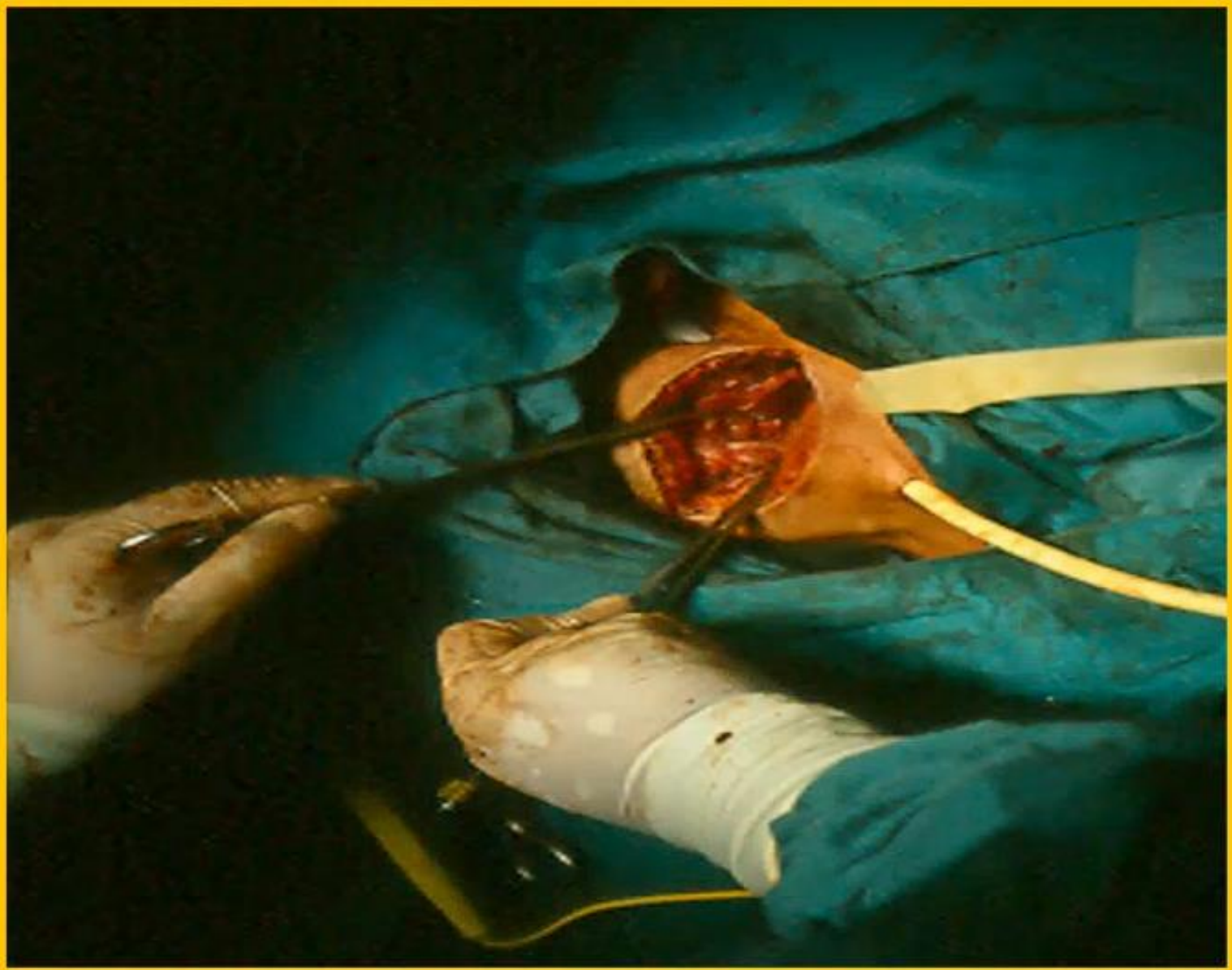
Dren Penrose
con esófago
liberado

PERFORACION DE ESOFAGO. TRAQUEOSTOMIA.

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



ECCEALOGOTOMIA CERVICAL

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

**TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEFINITIVO DE
LA PERFORACIÓN DE ESÓFAGO**

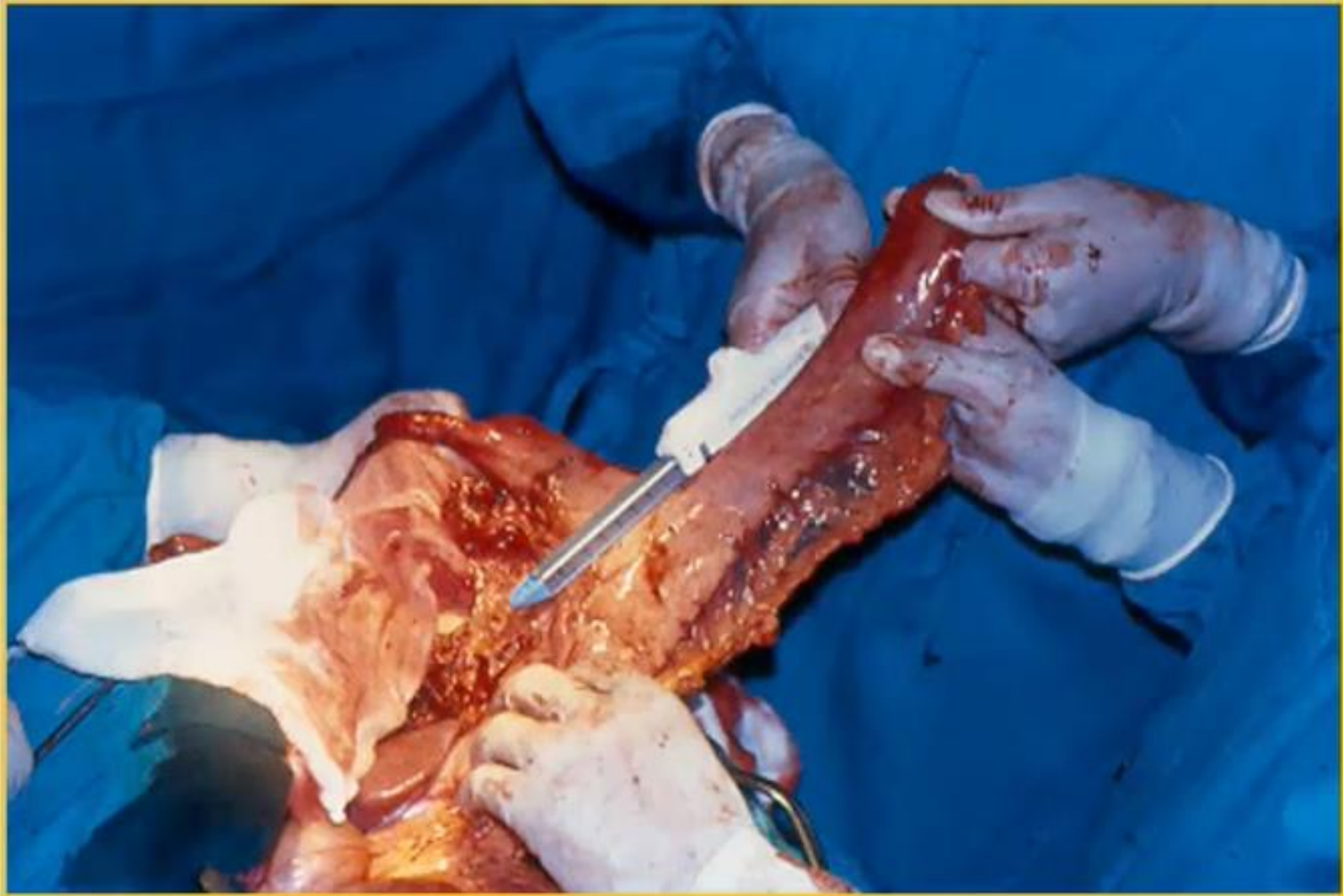


PERFORACION ESOFAGICA, DOBLE TUBO "G"

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

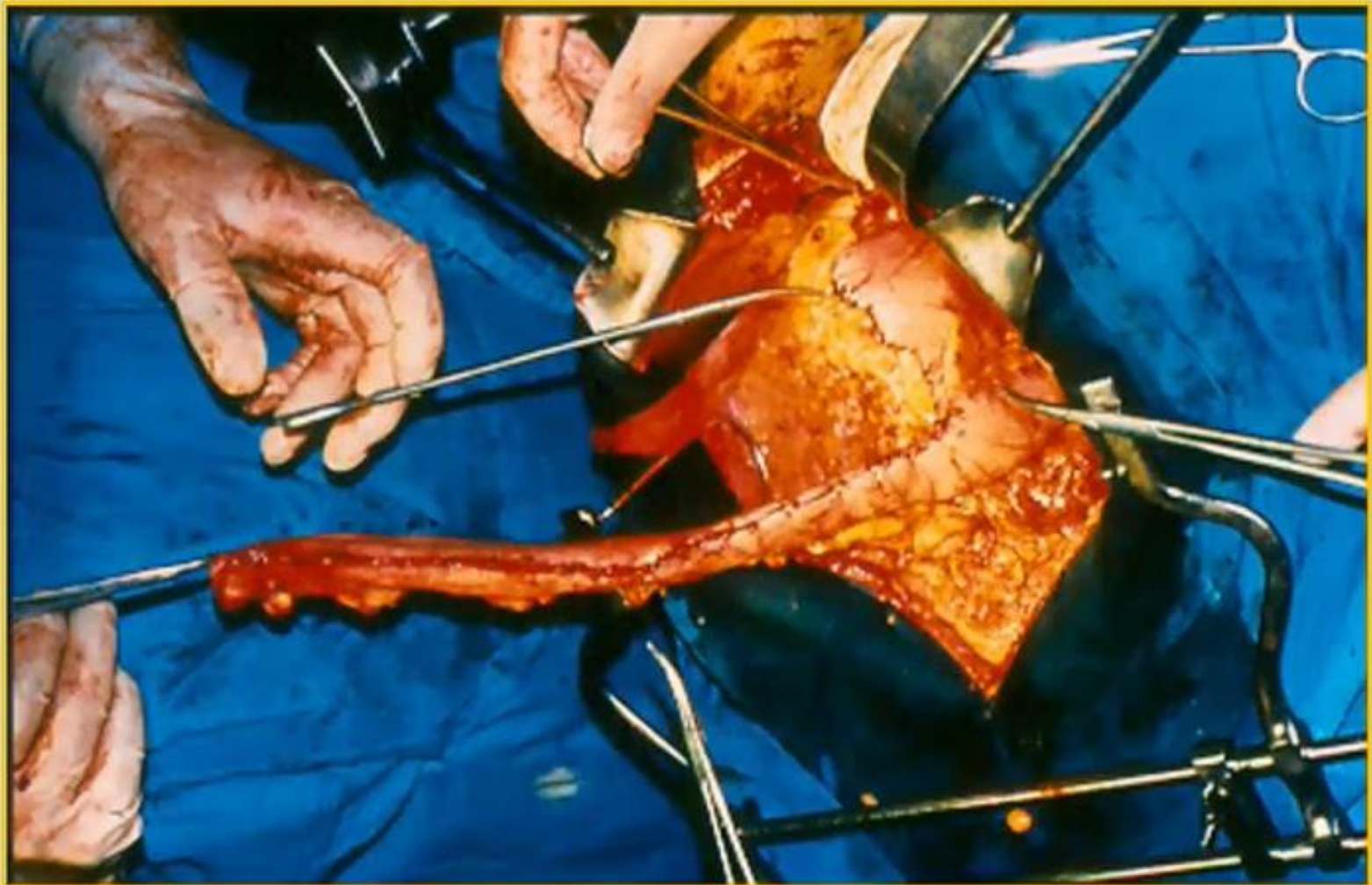


CANCER DE ESOFAGO. ESOFAGOGASTRECTOMIA. TUBO GASTRICO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



PERFORAC

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

STRICO



CANCER D

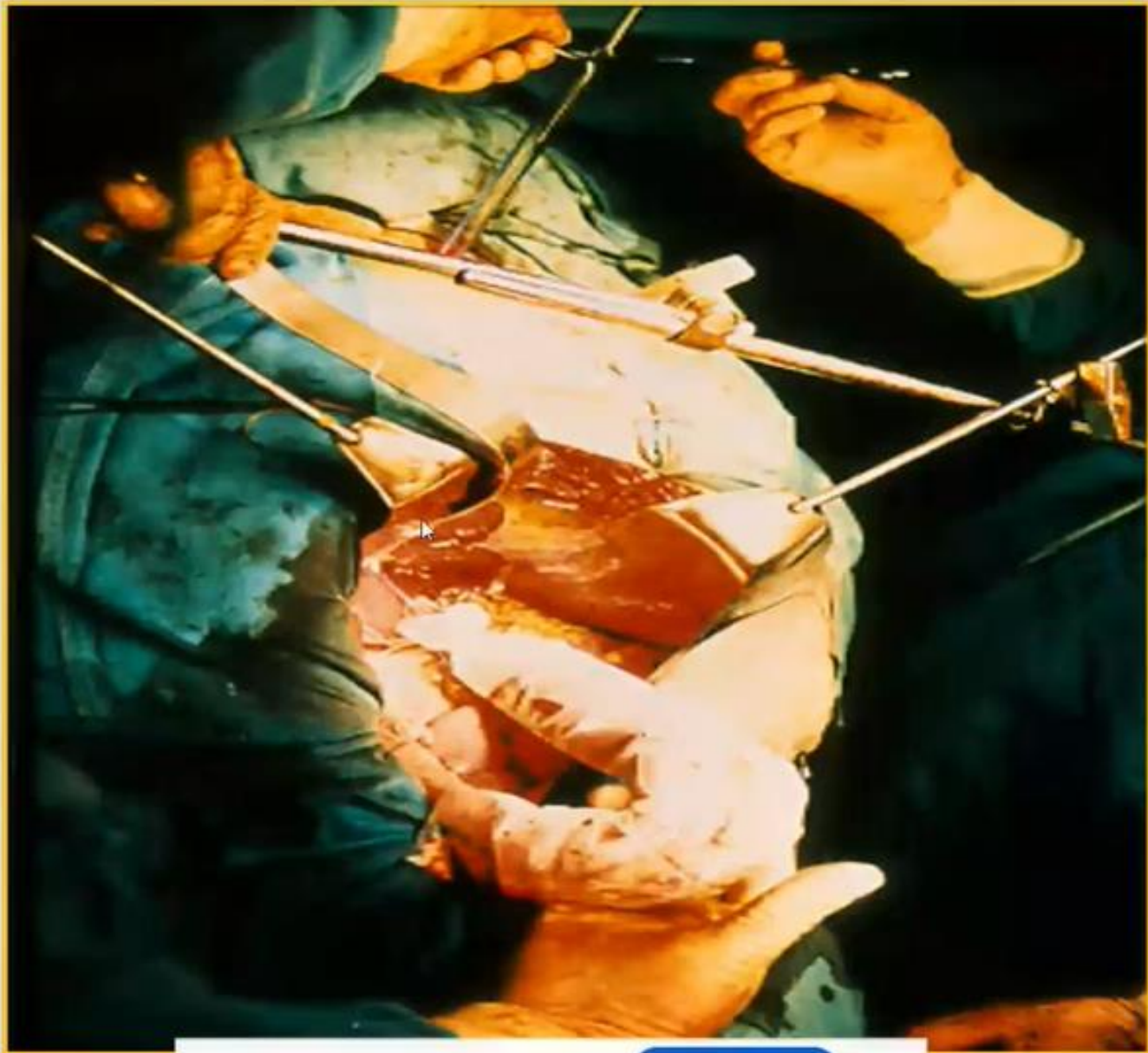
|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

MIA. TUBO

GASTRICO



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

CANCER DE ESOTAGO. TRANSPORTE.



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

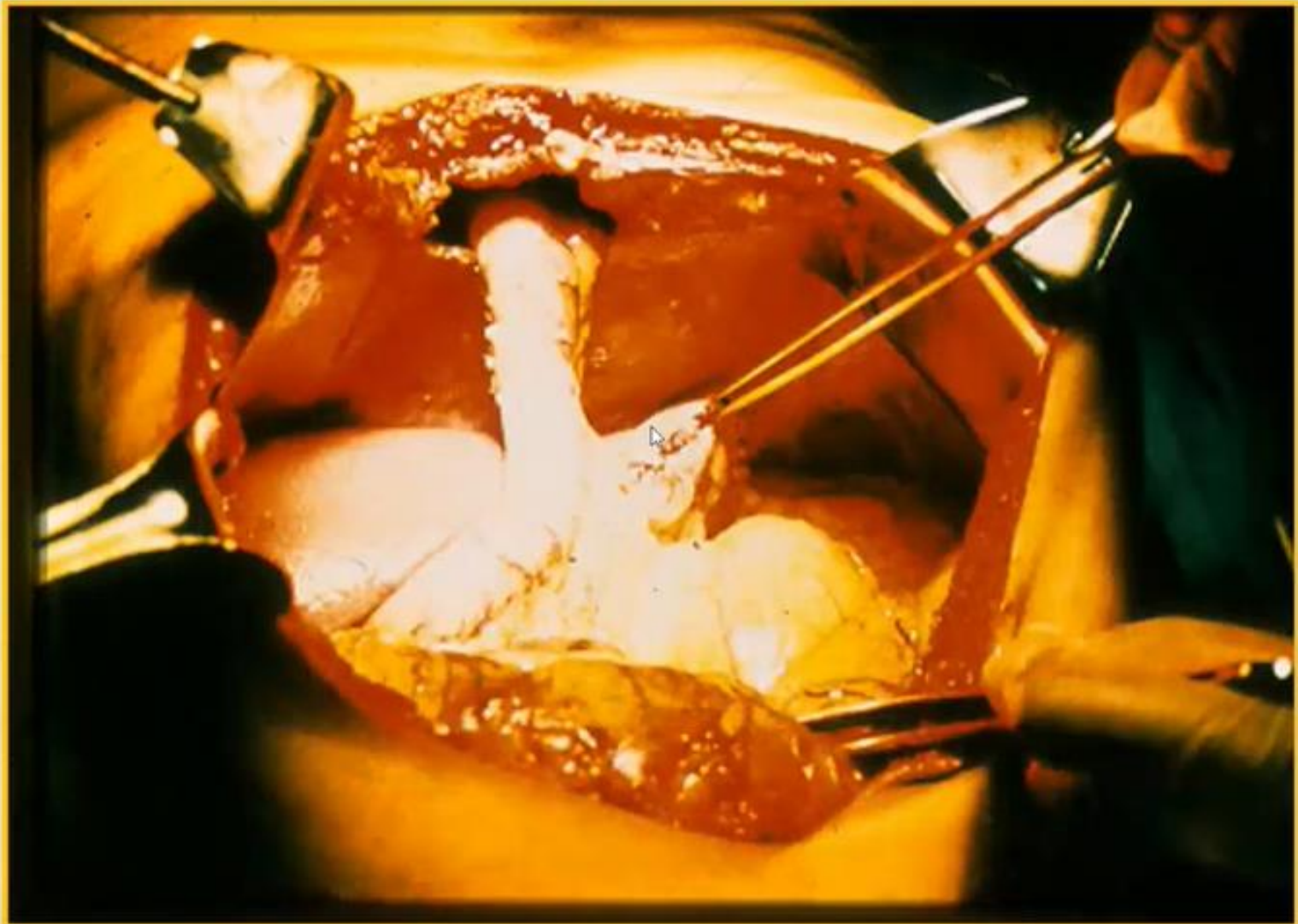
SINDROME DE BUENHABE



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

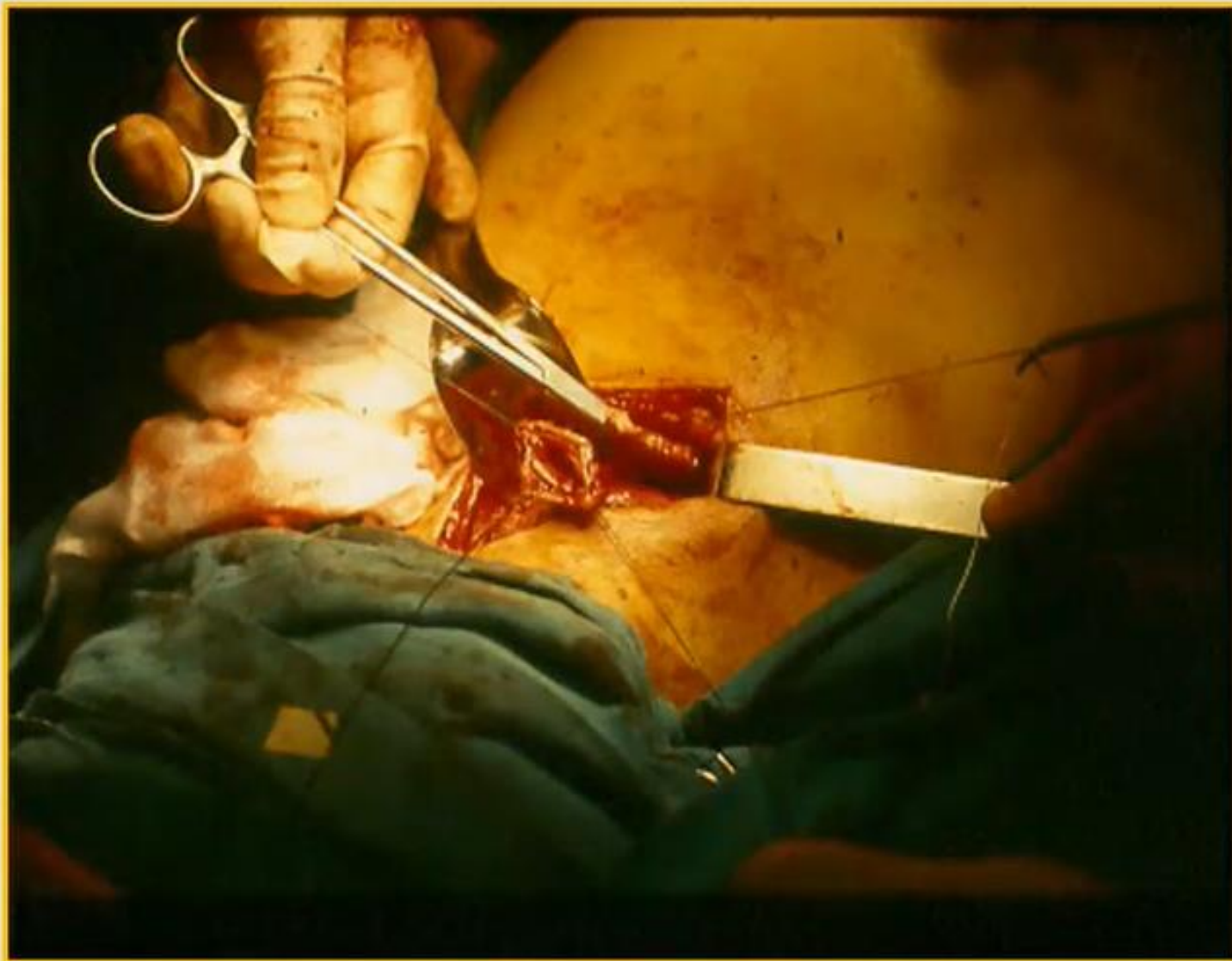


SINDROME DE ROEDAAVE TRANSPORTE

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



SIN

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

VICAL



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

CONTROL RADIOLOGICO POST-OPERATORIO



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

CONTROL RADIOLOGICO POST-OPERATORIO



**PACIENTE POST-OPERADO:
SINDROME DE
BOERHAAVE. DOBLE TUBO
GASTRICO**

**PACIENTE POST-
OPERADO POR
PERFORACION DE
ESOFAGO**



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



PACIENTE POST-OPERADO POR PERFORACION DE

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

FARINGOESOFAGOGASTRITIS CAUSTICA

Dr. Jáuregui Francia Filomeno
Lima - Perú

FARINGOESOFAGOGASTRITIS CAUSTICA

DEFINICION

**PROCESO QUIMICO E INFLAMATORIO
MOTIVADO POR AGENTES CAUSTICOS
CAPACES DE PRODUCIR LESIONES
DIRECTAS EN LAS PAREDES DEL
APARATO DIGESTIVO ALTO**



DISECCIÓN DE LAS ARTERIAS MESENTÉRICAS: ARCO DE

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



PACIENTE CON INGESTA DE SUSTANCIA CÁUSTICA

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

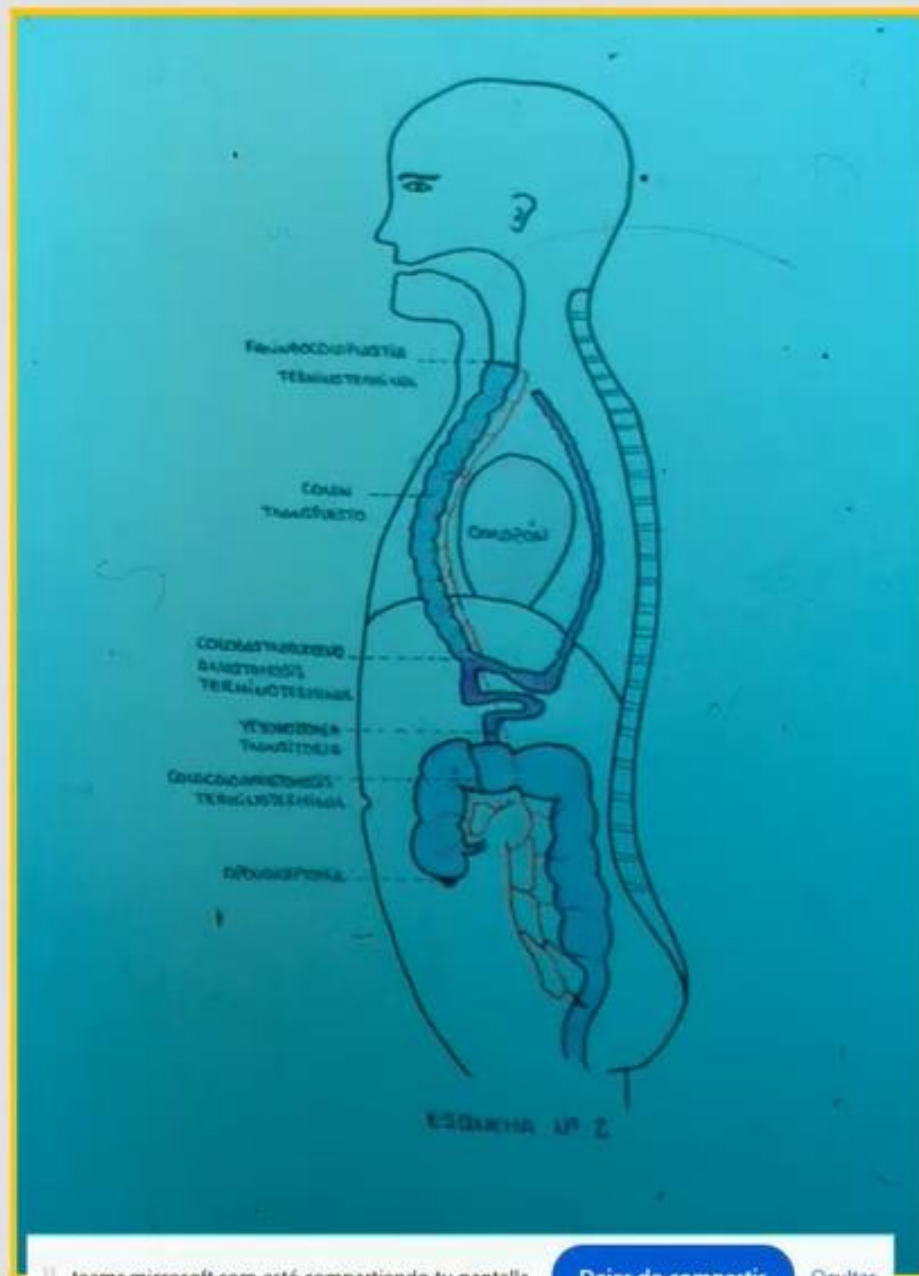
Dejar de compartir

Ocultar

PACIENT

OSTOMÍA,

ESTENOSIS ANTRO-PILÓRICA



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

TRANSPOSICION DE COLON

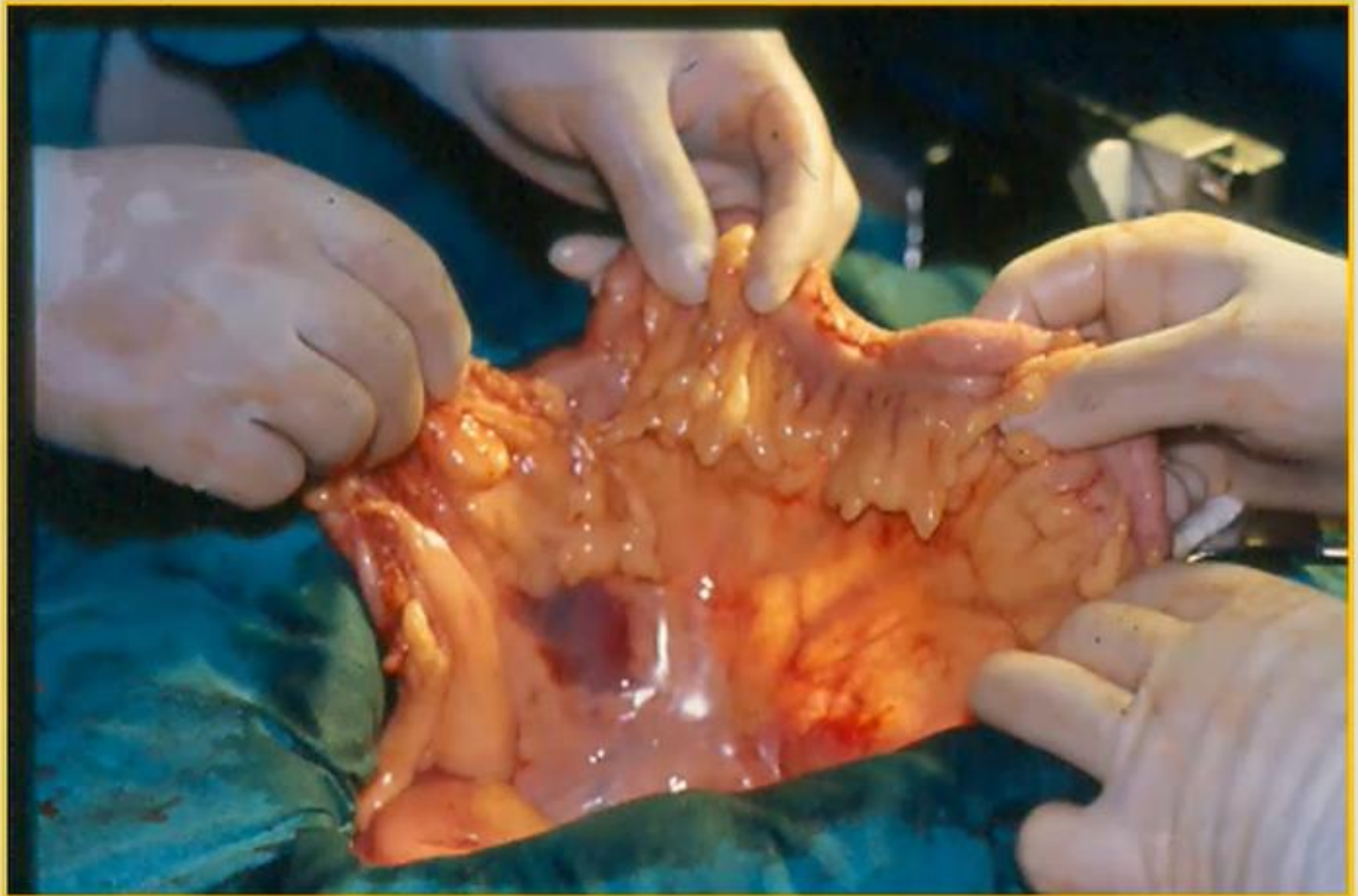


POSICIÓN || teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Quitar

GO

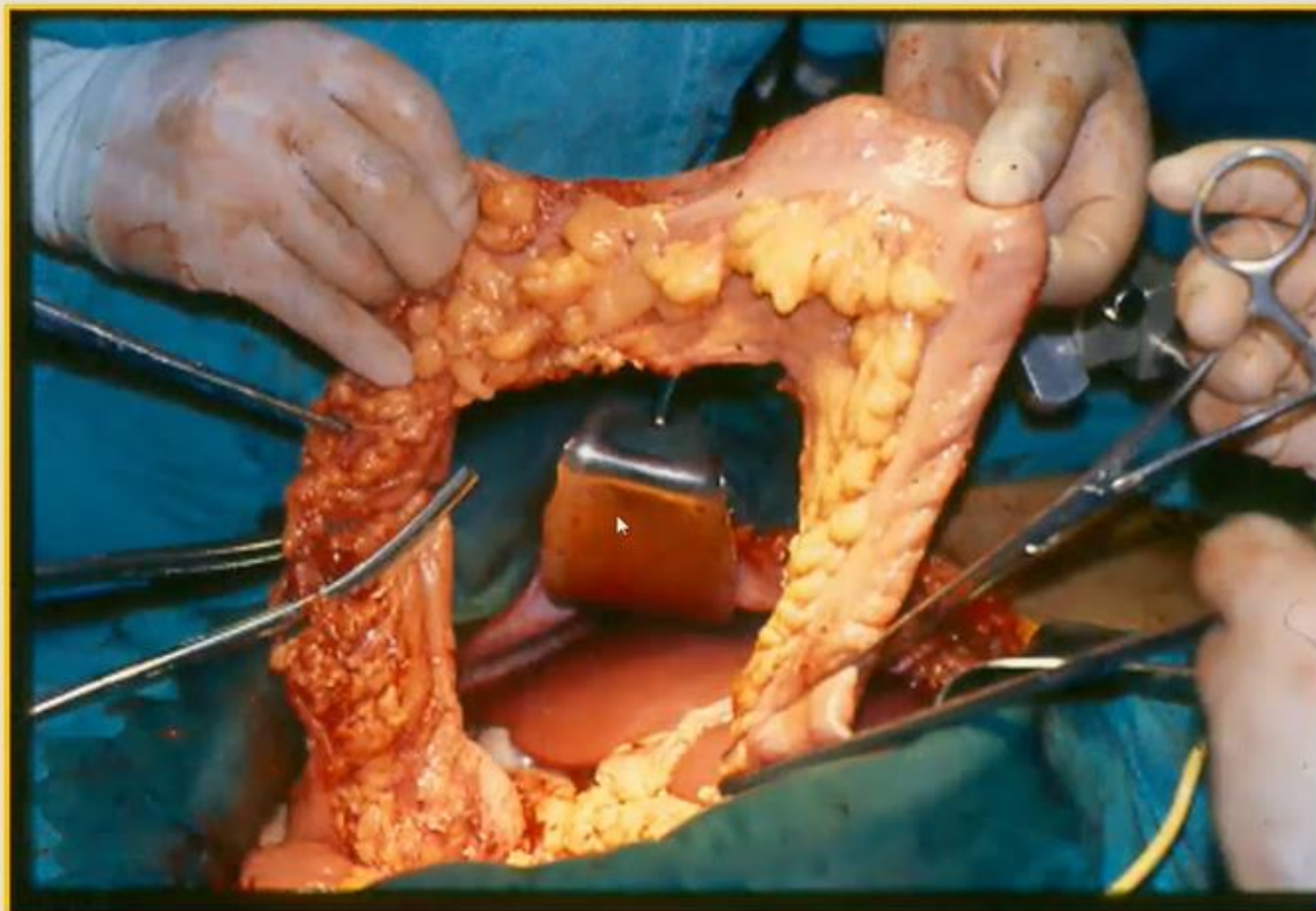


COLON

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



COLON A TRANSPONER

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

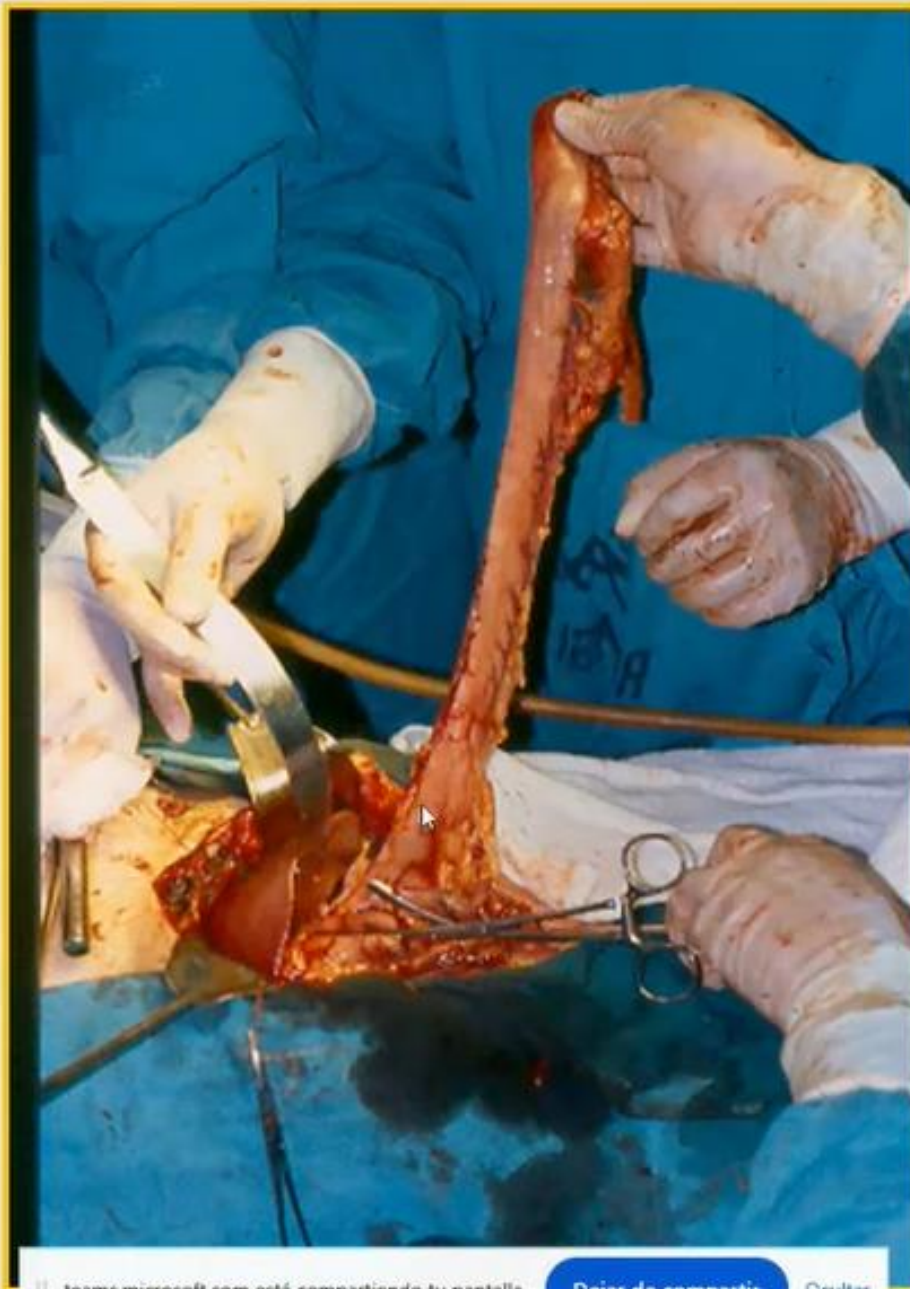


|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

ARCO VASCULAR DEL TUBO GÁSTRICO A TRANSPONER



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

TUBO GÁSTRICO COMO TRANSFERENTE POR MEDIASTINO ANTERIOR

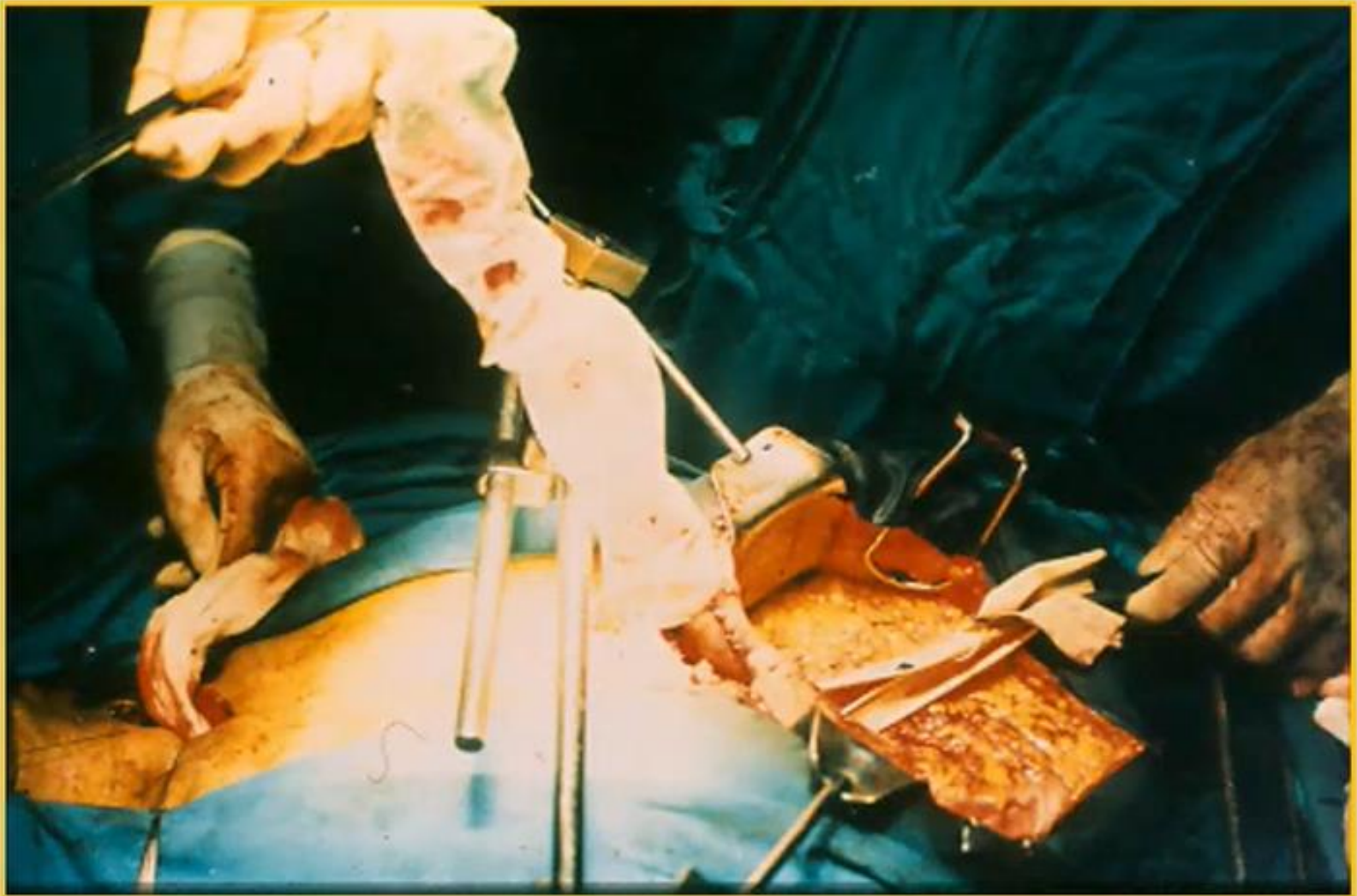


TUNELIZACIÓN DEL COLON ANTERIOR TRANSPOSICION DE

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



TRANSI

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

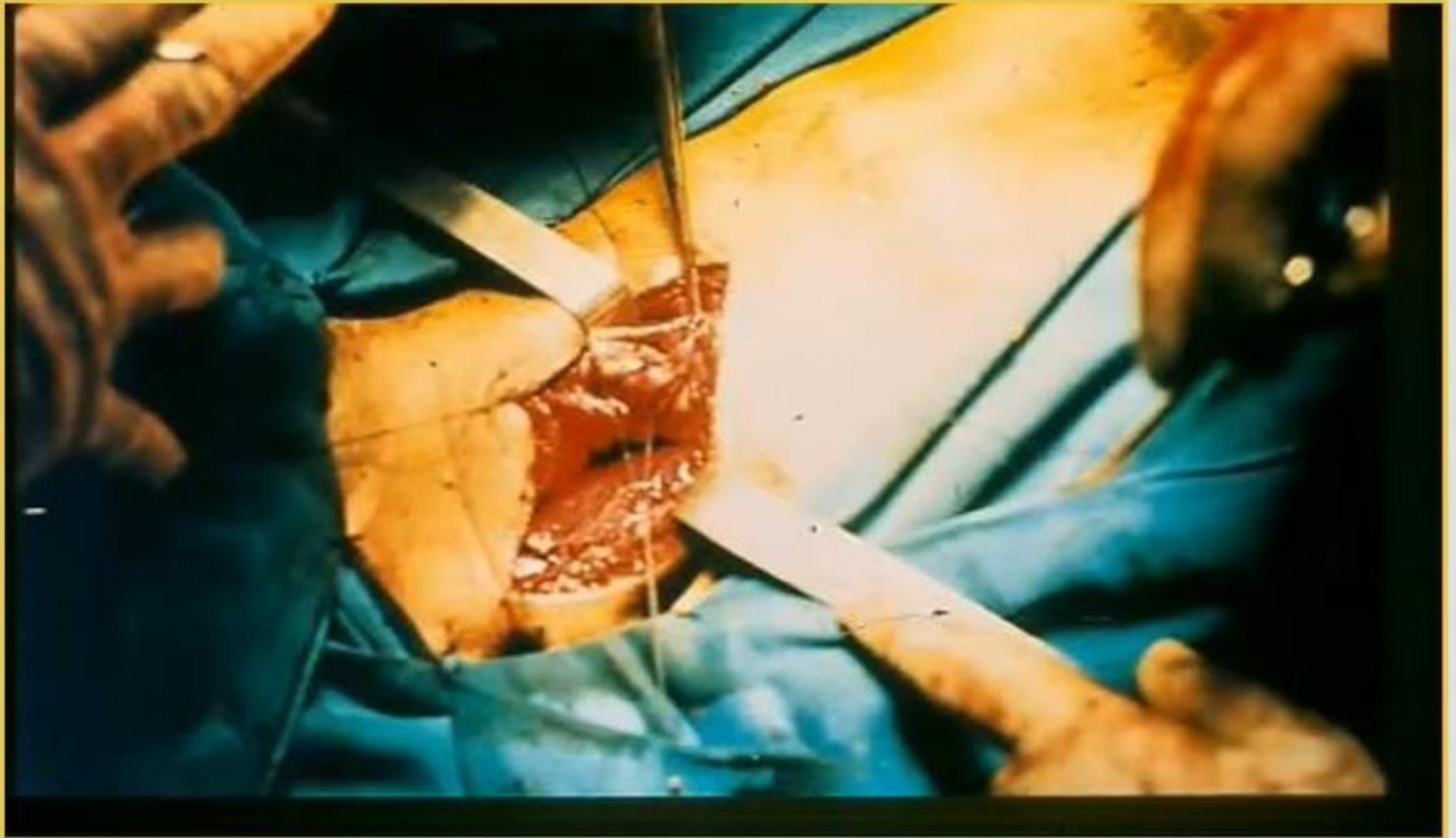
Ocultar



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

CERVICAL



SINDROME DE ROERHAAVE DOBLE TUBO GÁSTRICO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



PACIENTE POST-OPERADA POR ESOFAGITIS

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



FINALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE COLON

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

OPORTUNIDADES POR ESOFAGITIS CÁUSTICA



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



CERVICOTORACIC LAPAROTOMÍA POR ESOFAGITIS

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



CERVICOTOMIA TORACICOTOMIA POR ESOFAGITIS

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



PACIENTE CON VENTRICULOSTOMÍA Y TRACHEOSTOMIA

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



PACIENTES POST-OPERADAS POR

ES

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

OROFARINNGOCOLONICO



PACIENTE POST OPERADA POR ESCOCELITIS

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



TRANSPOSICIÓN DE COLON DE REGIÓN PRE

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



PACIENTE POST OPERADA POR ESCOLOCITIS

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



CÁNCER DE ESÓFAGO – CARDIAS

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

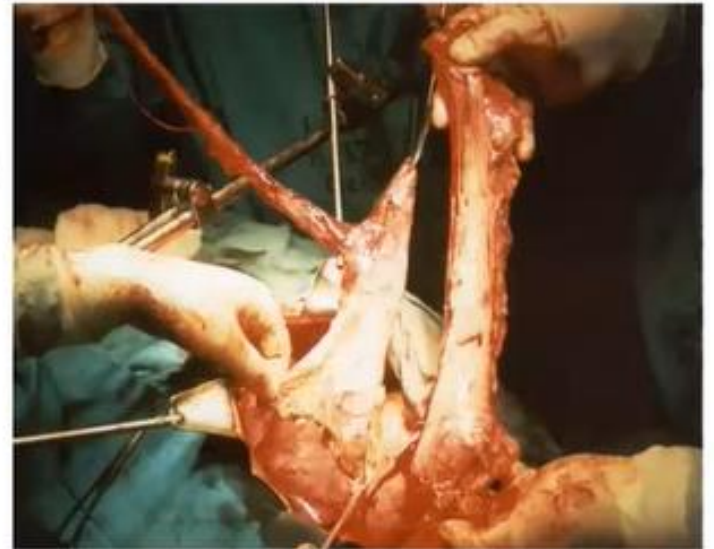
CANCER DE ESÓFAGO

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

- **CLASIFICACION TNM,
PARA LA ESTADIFICACIÓN DEL
CANCER ESOFÁGICO.**

4 SECTORES:

- 1.- ESÓFAGO CERVICAL**
- 2.- ESÓFAGO TORÁCICO SUPERIOR**
- 3.- ESÓFAGO TORÁCICO MEDIO**
- 4.- ESÓFAGO INFERIOR**



CLASIFICACIÓN PATOGENICA Y TERAPÉUTICA DEL ADENOCARCINOMA DE LA UNIÓN ESOFAGOGÁSTRICA (AEG)

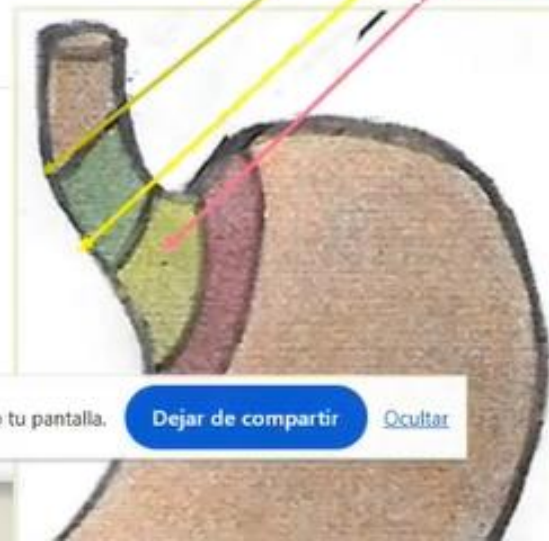
CLASIFICACIÓN SIEWERT'S

Tipo I : ADENOCARCINOMA DEL ESÓFAGO DISTAL

Tipo II : CARCINOMA VERDADERO DE CARDIAS

Tipo III : CARCINOMA SUBCARDIAL

Tipo I	Adenoca de Esófago distal
Tipo II	Carcinoma del cardias
Tipo III	Carcinoma Subcardial



ESOFAGUECTOMIA TRANSHIATAL

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

ESOFAGUECTOMIA TRANSHIATAL

TIEMPOS OPERATORIOS DE LA FASE DEFINITIVA

- TIEMPO ABDOMINAL
- TIEMPO TORACICO
- TIEMPO CERVICAL



POSICIÓN DEL PACIENTE

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

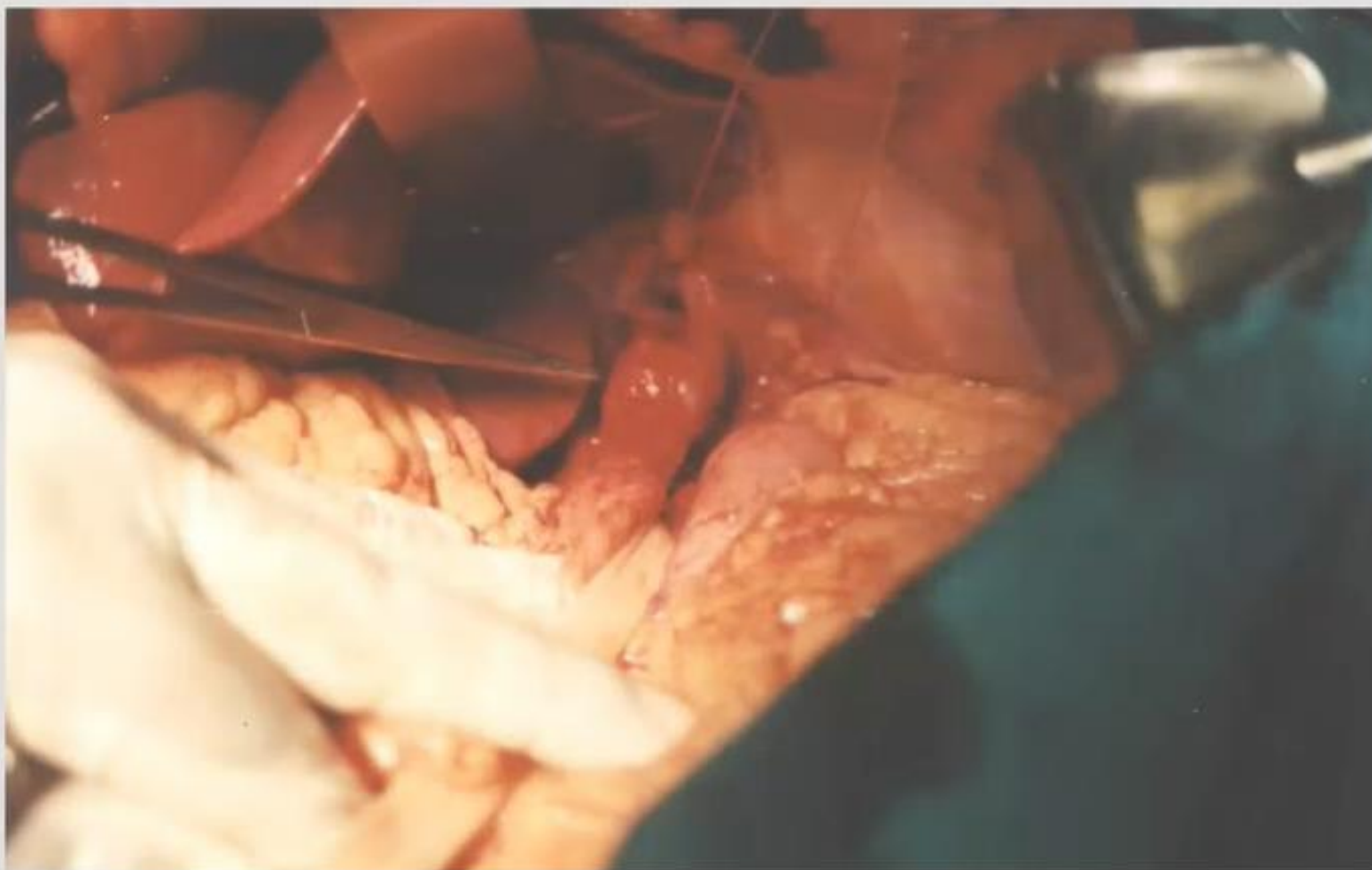


TIEMPO ABDOMINAL LIBERACIÓN DE ESÓFAGO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

[Ocultar](#)

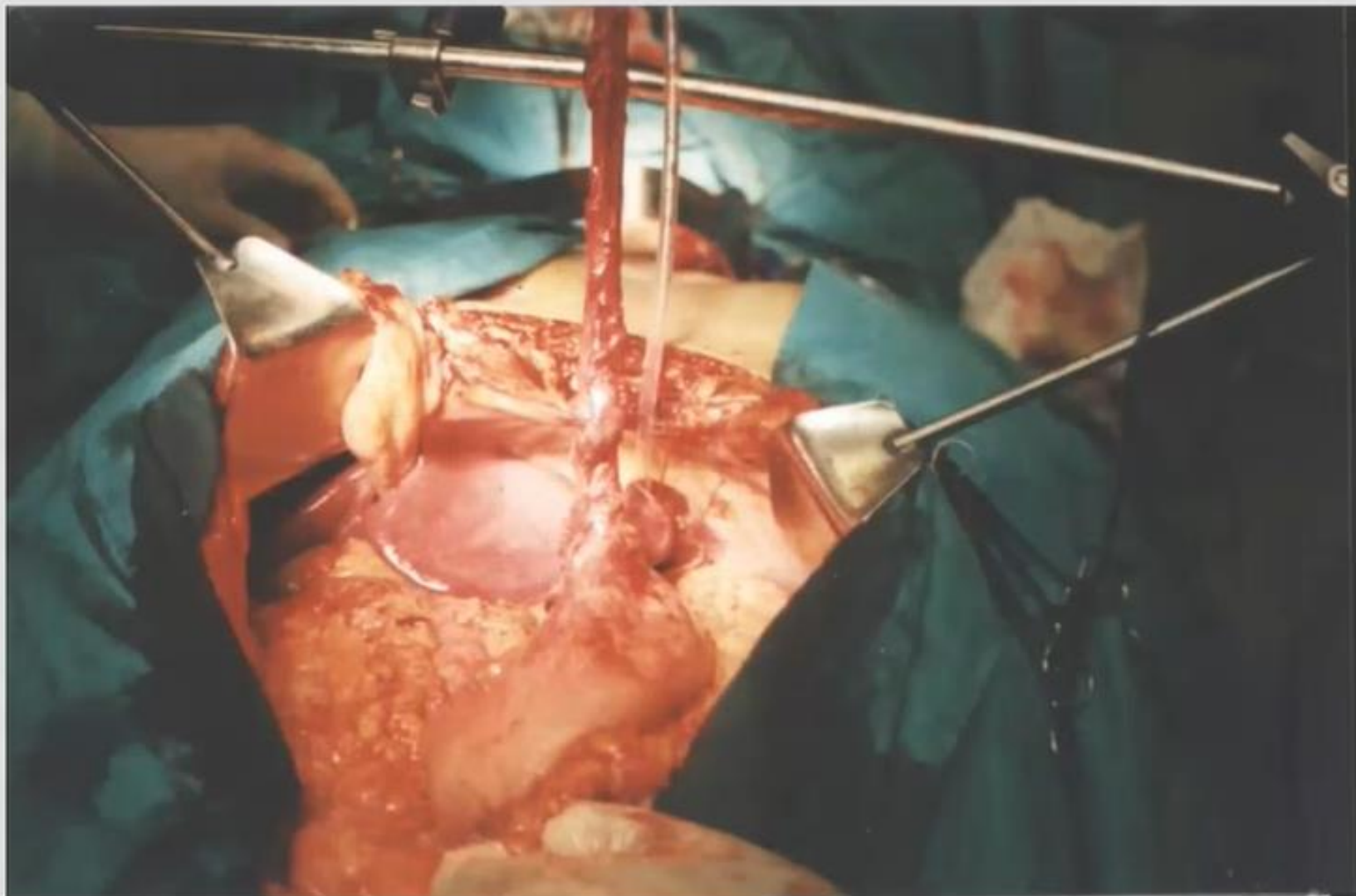


TUMOR DE ESÓFAGO DISTAL

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

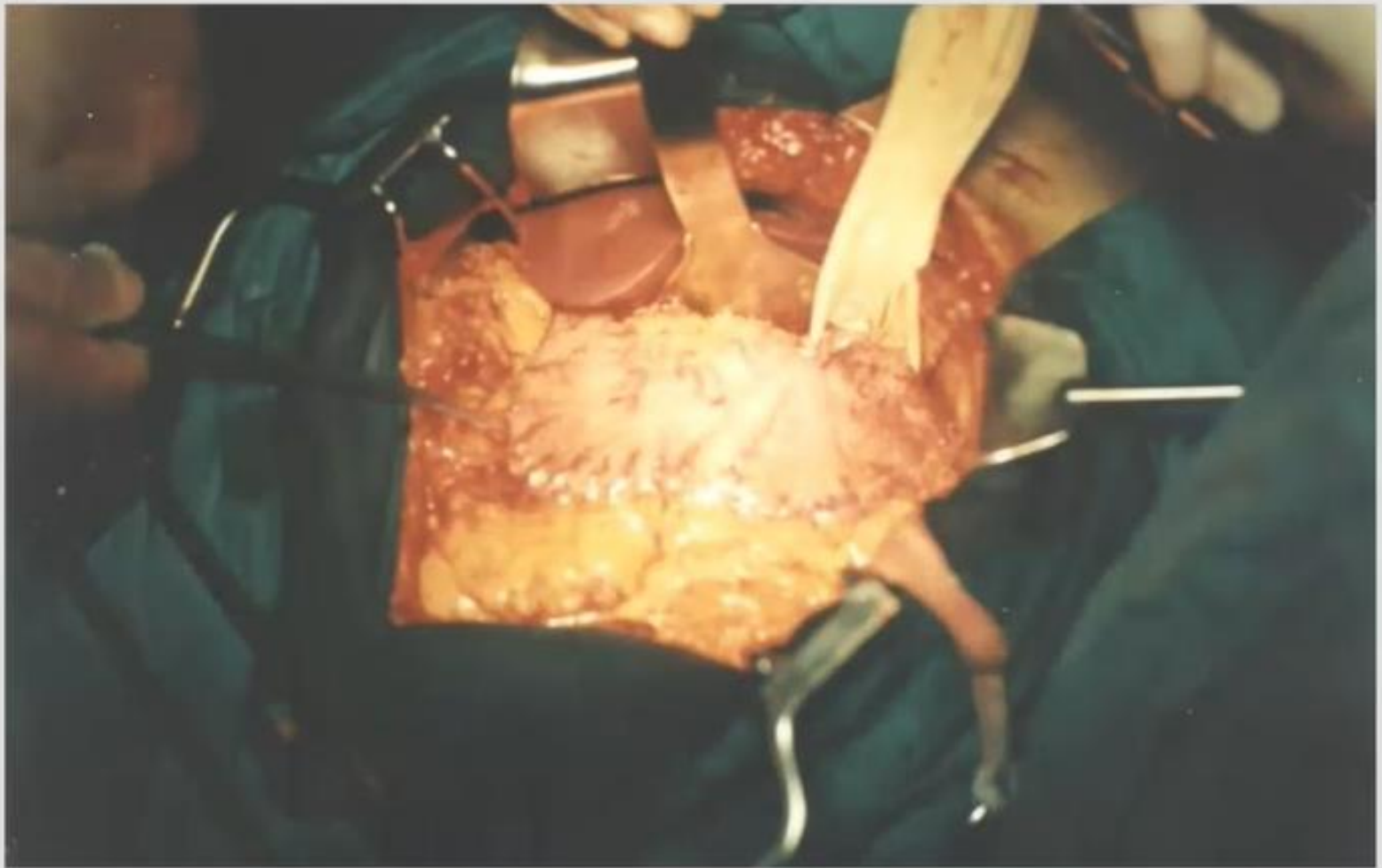


ESOFAGECTOMIA : GASTRECTOMIA PROXIMAL

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

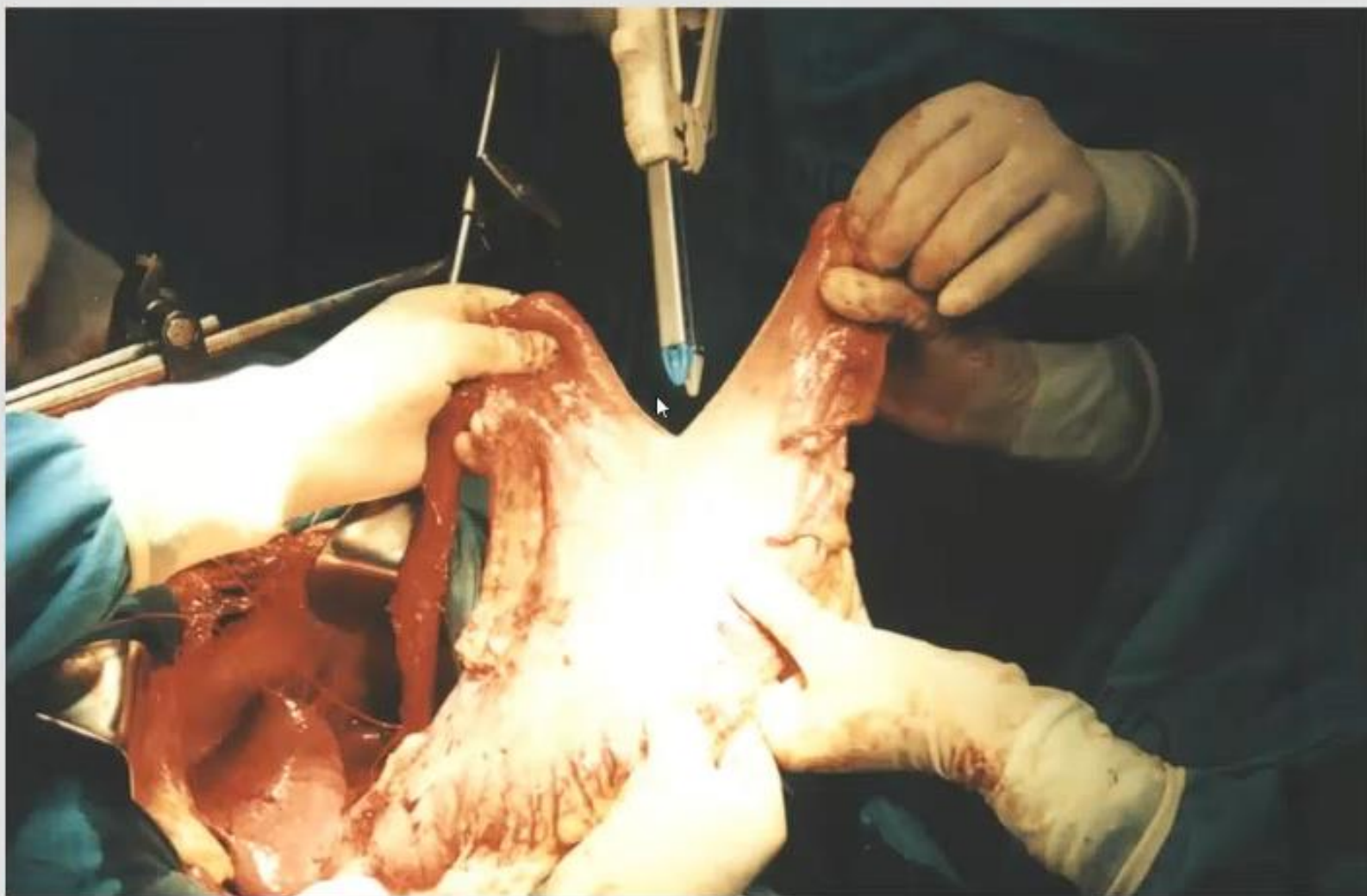


ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar



PREPARACIÓN DE TUBO GÁSTRICO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

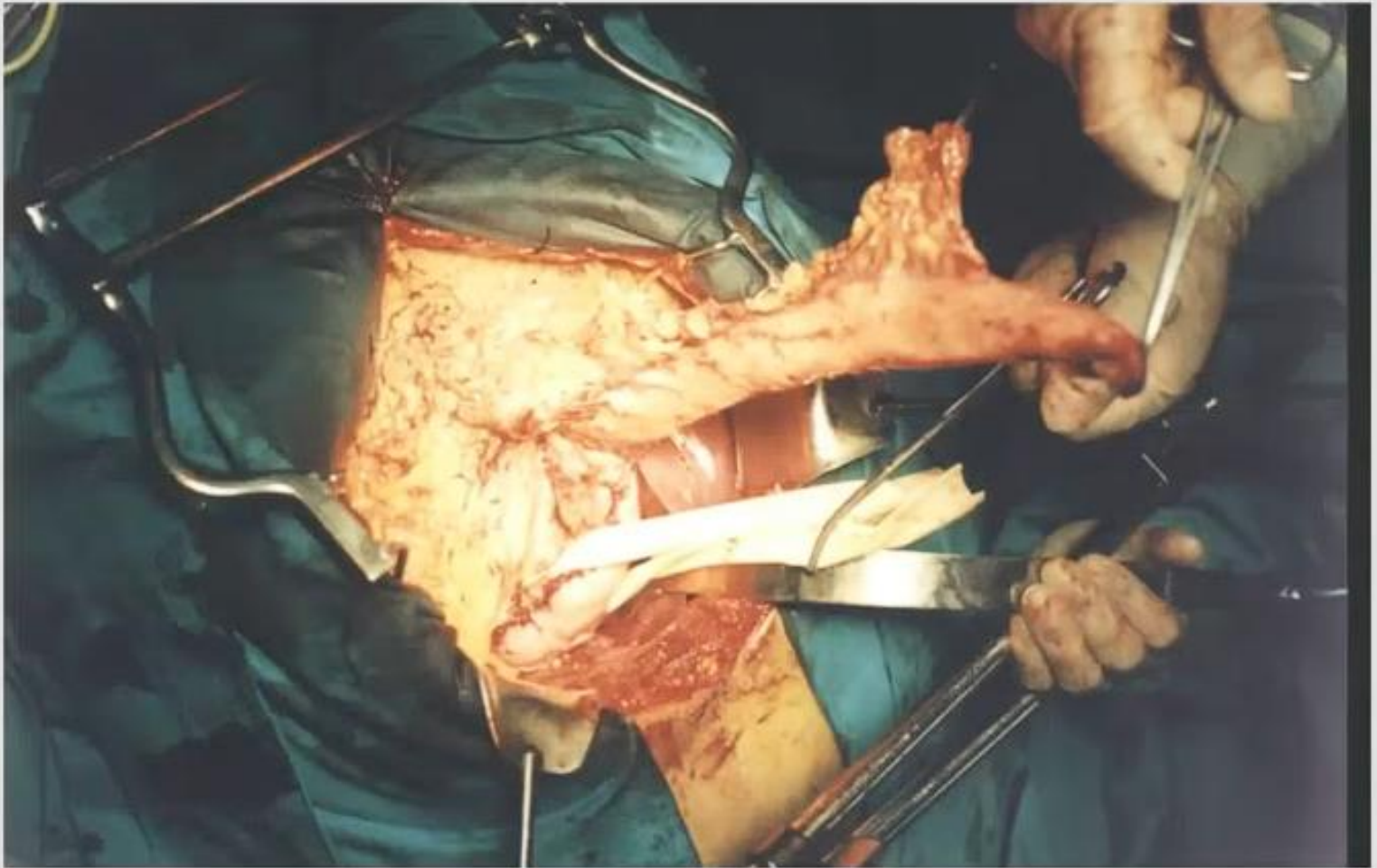


TIPO GÁSTRICO A TRANSVERSO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

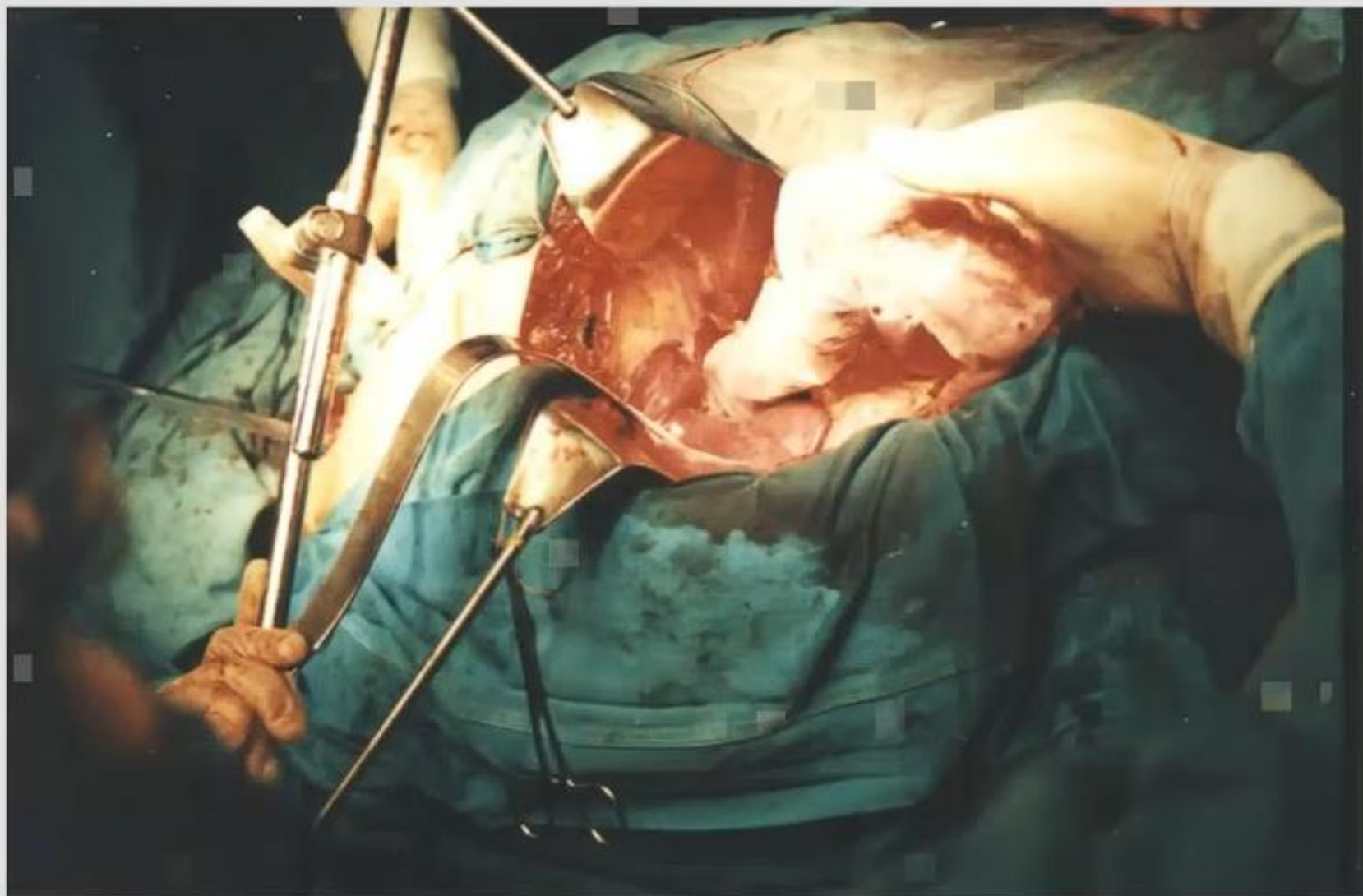


DOBLE YUGO GÁSTRICO

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)

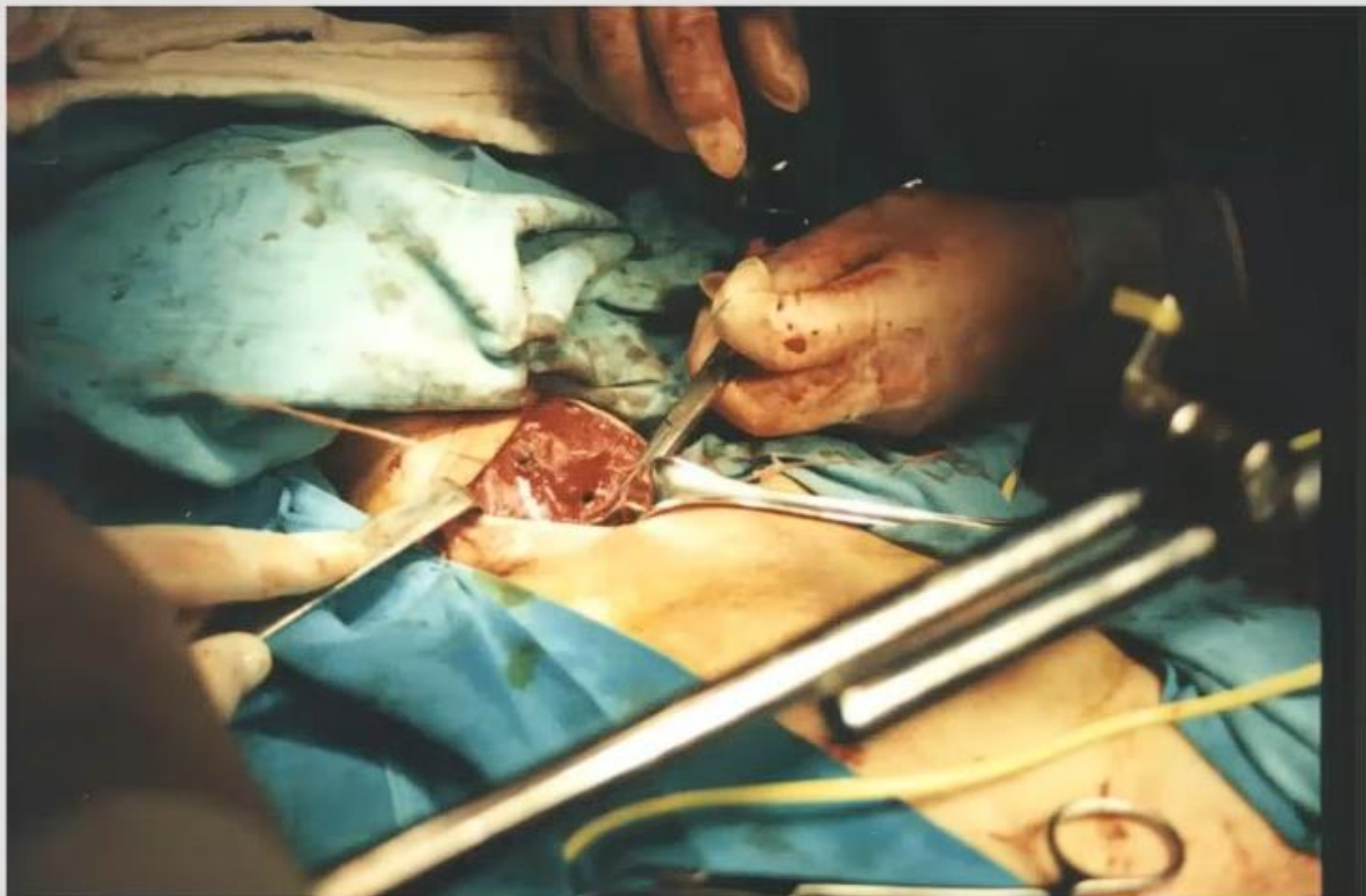


TRANSPOSICIÓN DE TUBO GÁSTRICO POR

|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

[Dejar de compartir](#)

[Ocultar](#)



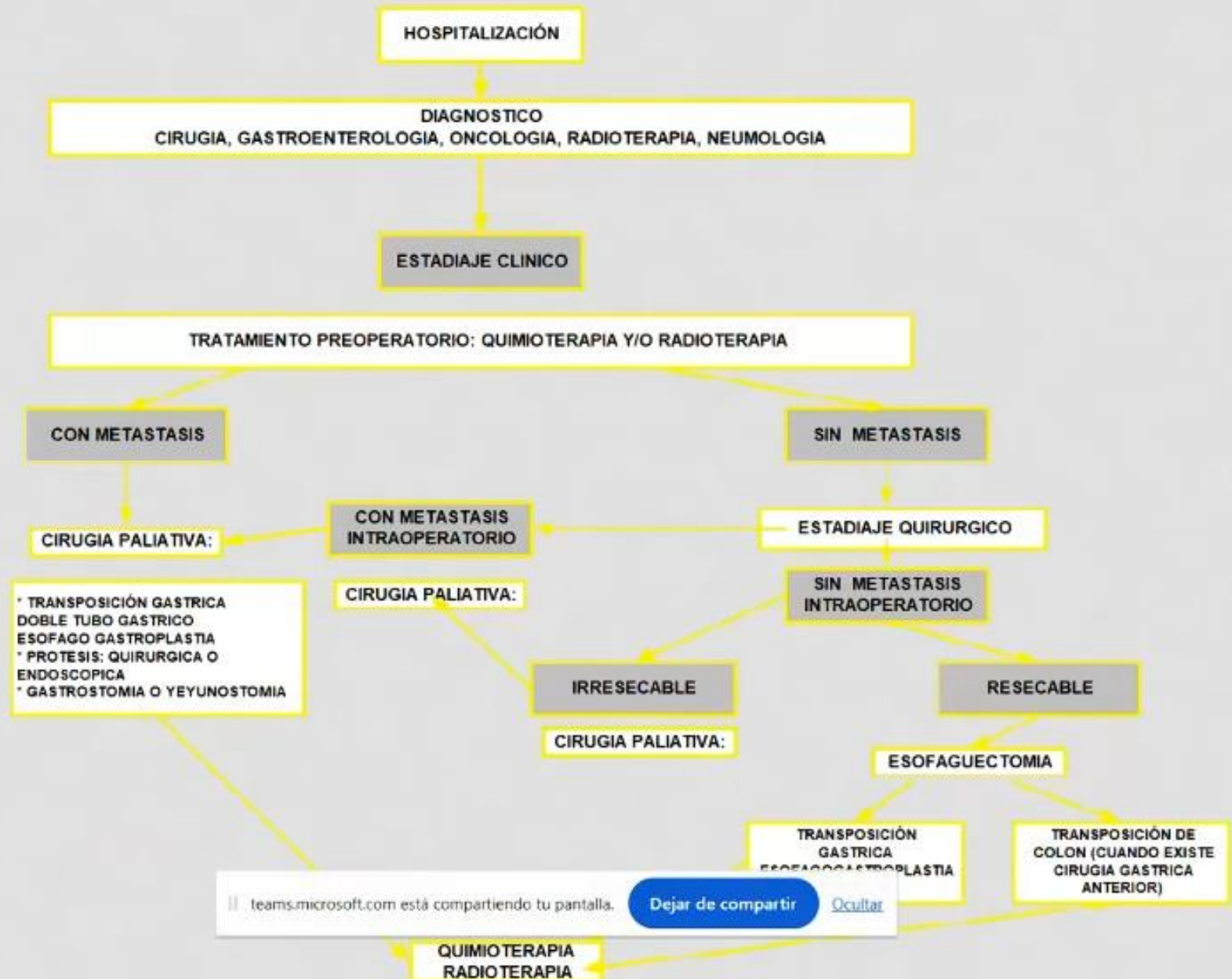
TIEMPO CERVICAL IDENTIFICACIÓN DEL ESOFAGO

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

PROTOCOLO DEL CANCER DE ESOFAGO



PROTOCOLO DEL CANCER DE ESOFAGO

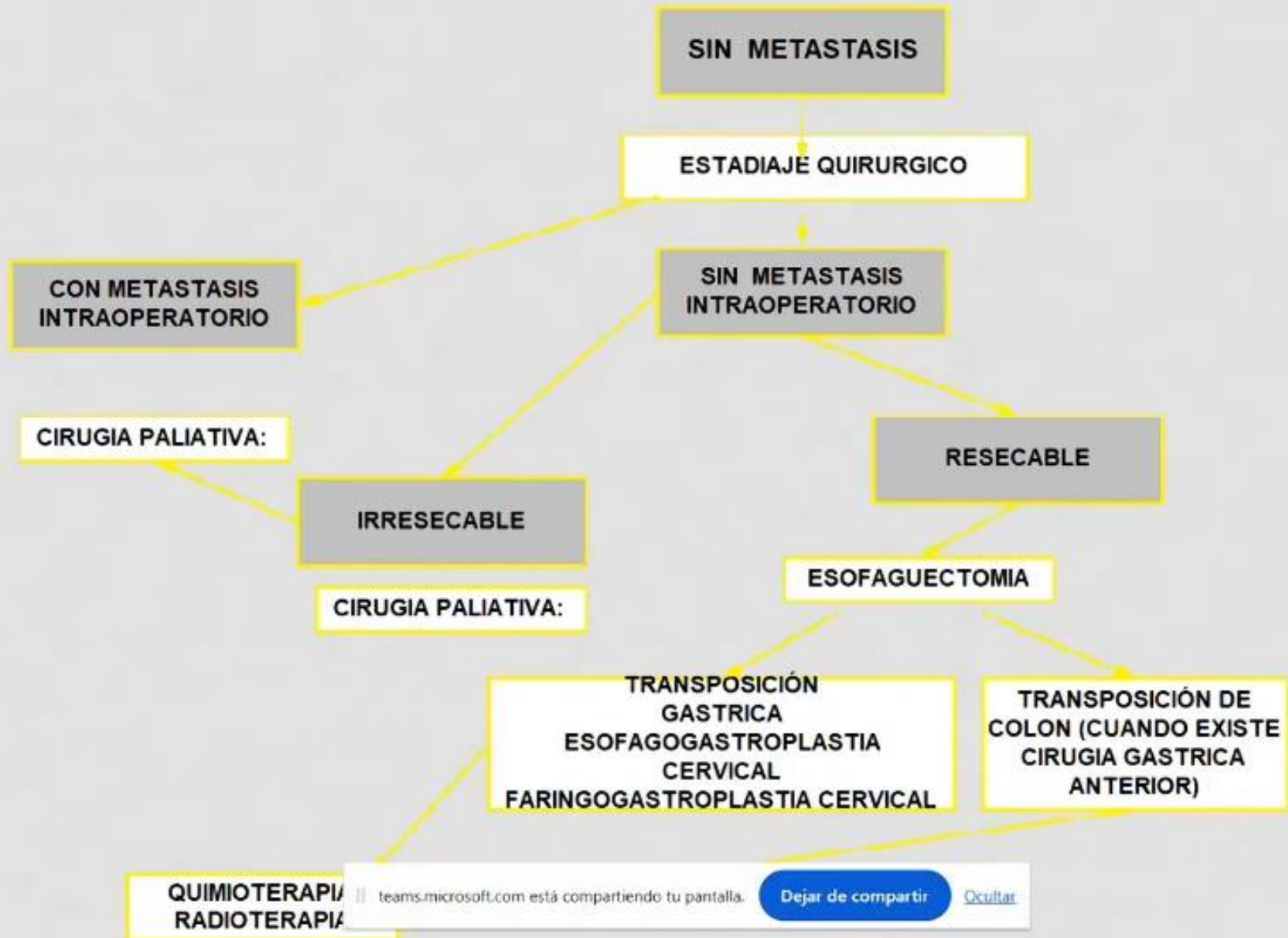
CON METASTASIS

CIRUGIA PALIATIVA:

- * TRANSPOSICIÓN GÁSTRICA
- DOBLE TUBO GÁSTRICO
- ESOFAGO GASTROPLASTIA
- * PROTESIS: QUIRÚRGICA O ENDOSCÓPICA
- * GASTROSTOMIA O YEYUNOSTOMIA
- * DRENAJE

**QUIMIOTERAPIA
RADIOTERAPIA**

PROTOCOLO DEL CANCER DE ESOFAGO



CANCER DE FARINGOLARINGE Y ESOFAGO CERVICAL

- Faringoesofaguectomía
- Laringuectomía.
- Faringogastroplastía cervical.
- Faringocoloplastía cervical.
- Drenaje

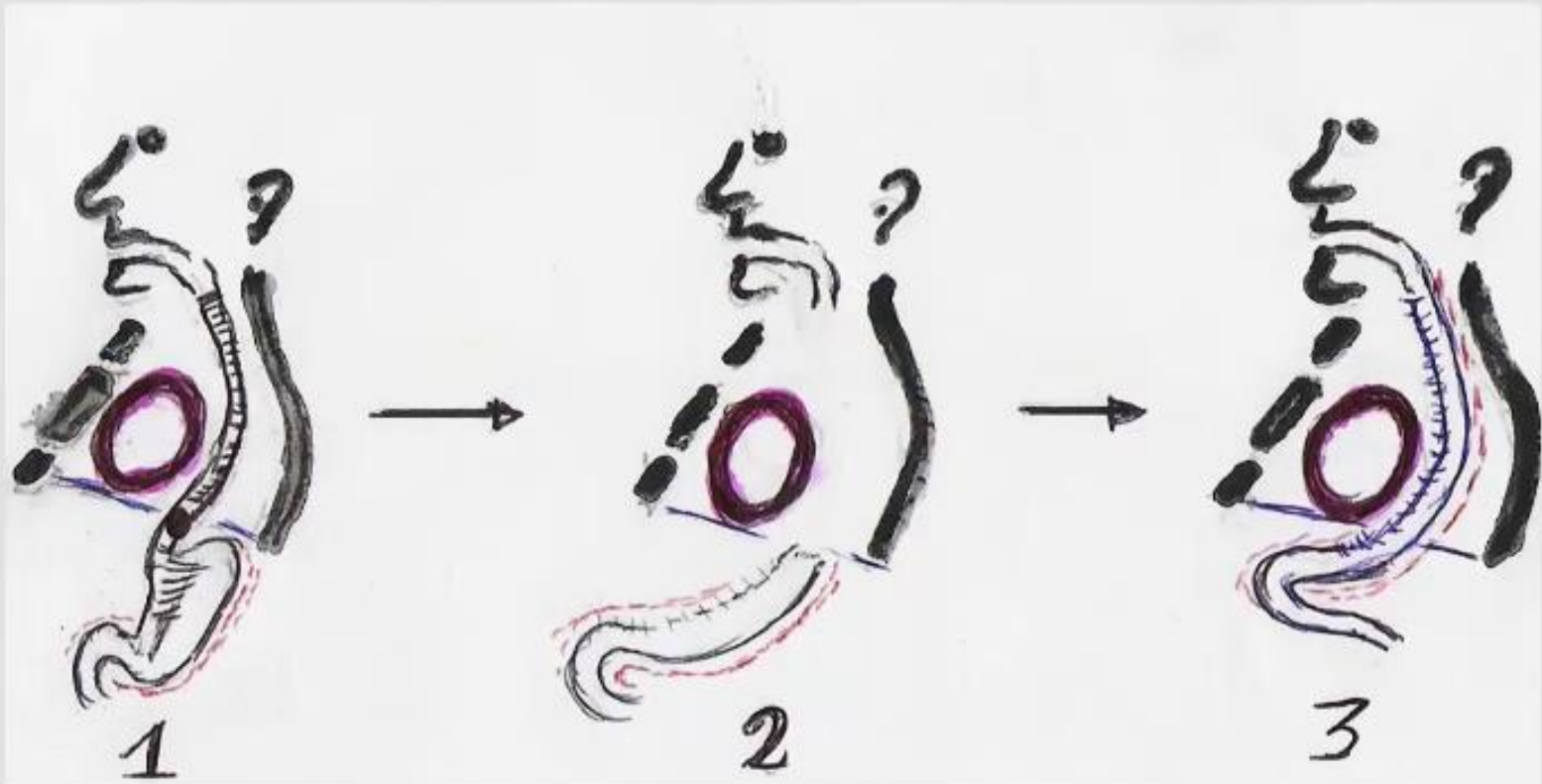
CANCER DE ESOFAGO DE TERCIO MEDIO

- Toracotomía derecha.
- Toracotomía laparoscópica.
- Esofaguectomía.
- Esofagogastroplastía cervical.
- Faringogastroplastía cervical.
- Faringocoloplastía cervical.
- Drenaje.

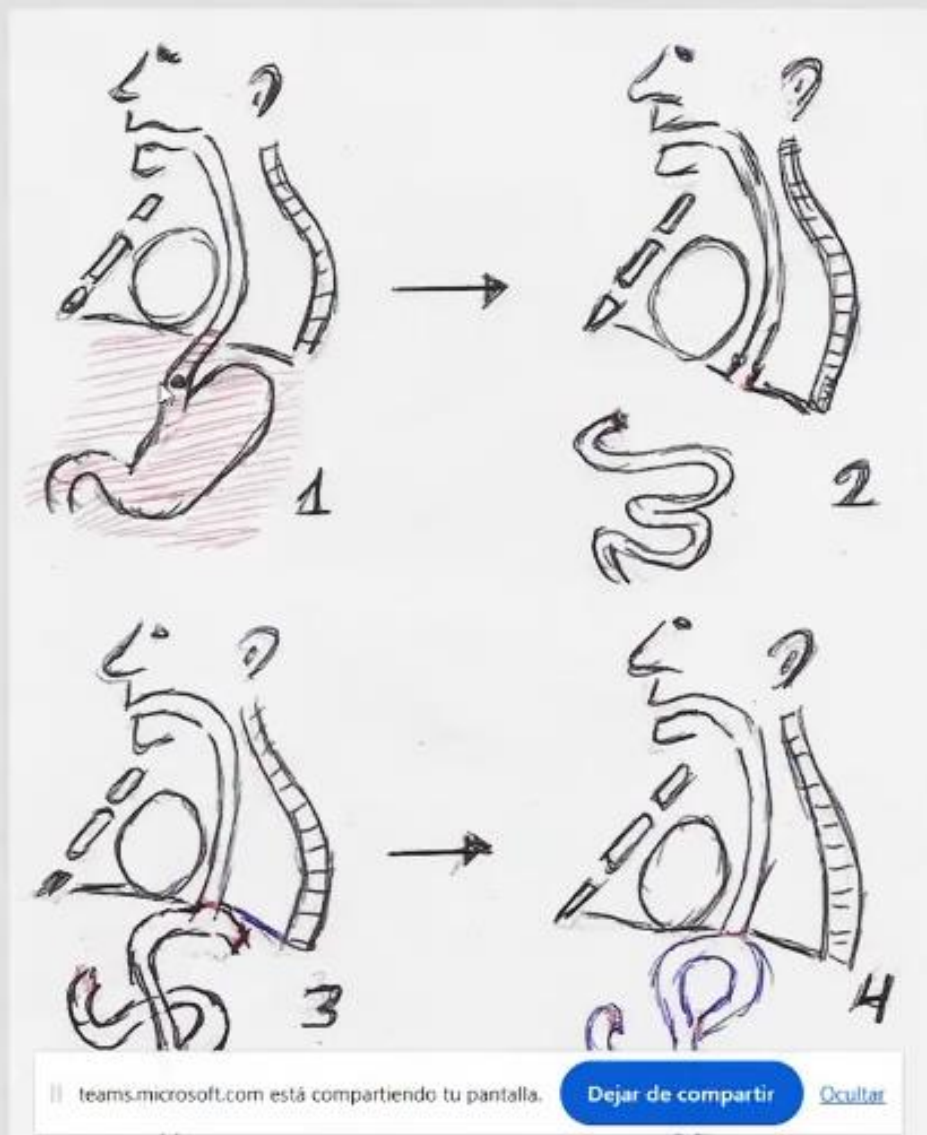
CANCER DE ESOFAGO DISTAL

- Esofaguectomía transdiafragmática, transmediastínica.
- Esofagogastroplastía cervical.
- Faringogastroplastia cervical.
- Faringocoloplastía cervical.
- Drenaje.

CIRUGIA DE CARDIAS TIPO I



CIRUGIA DE CARDIAS TIPO II



CIRUGIA DE CARDIAS TIPO III

